

Voorbeeldvragen ter verduidelijking en beïnvloeding van het Wlz inkoopbeleid 2027 - 2029

Wlz inkoopbeleid 2027 – 2029

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni 2026 de landelijke visie voor 2027 – 2029 en de gezamenlijke onderbouwing van de tariefsystematiek beschikbaar gesteld. Zorgkantoren hebben daarnaast hun regionale Wlz inkoopbeleid 2027- 2029 en aanvullende documentatie gepubliceerd. ActiZ heeft analyses opgesteld van het inkoopbeleid van zorgkantoren en voorbeeldvragen opgesteld ter verduidelijking en beïnvloeding van het Wlz inkoopbeleid 2027 – 2029. Alle vragen/bezwaren kunt u gebruiken bij uw reactie richting het zorgkantoor.

Inhoudsopgave

Tijdpad zorginkoop 2027-2029.....	2
Kortgedingprocedures	3
Rechtsverwerking	4
Rechtsmiddelen.....	4
Voorbeeldvragen	5
Vragen over landelijk beleid.....	5
I. Vragen over Landelijk Beleidskaders Wlz 2027 (ZN)	5
II. Vragen bij Overeenkomst Wlz 2027-2029.....	13
III. Vragen over Onderbouwing vertrektarieven Wlz 2027	16
Specifieke vragen over het Wlz inkoopbeleid 2027 – 2029 van zorgkantoren	18
Zorgkantoor Zilveren Kruis	18
Zorgkantoor CZ.....	26
Zorgkantoor Menzis	31
Zorgkantoor VGZ.....	38
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.....	43
Zorgkantoor DSW	45
Zorgkantoor Salland	47
Concept bezwaarbrief i.r.t. Zorginkoopbeleid	50

Tijdpad zorginkoop 2027-2029

Het zorginkoopbeleid kent een door de zorgkantoren bepaald vast tijdpad, dat in hoofdlijnen bestaat uit:

- Publicatie van het zorginkoopbeleid;
- Een periode voor het stellen van vragen via de Nota van Inlichtingen ("NvI");
- Publicatie van de NvI;
- Afronding van de inkoop en contractering.

Binnen dit tijdpad bestaan verschillende procedurele mogelijkheden die u als zorgaanbieder eventueel kunt benutten. Het moment waarop deze worden benut, kan van grote invloed zijn op wat later nog aan de orde kan worden gesteld. Het tijdpad wordt hieronder schematisch weergegeven.

Fase	Datum
1. Publiceren Zorginkoopbeleid Wlz 2027-2029	1 juni 2026 12:00 uur
2. Indienen van <u>vragen</u> t.b.v. Nota van Inlichtingen (NvI) a. Vragen worden ingediend om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. b. Van belang: het stellen van vragen is <u>onvoldoende</u> om rechtsverwerking te voorkomen. In dat geval moet bezwaar worden gemaakt.	Tot uiterlijk 15 juni 2026 12.00 uur
3. Het indienen van bezwaar om rechtsverwerking te voorkomen a. Op grond van het Zorginkoopbeleid, kunt u alleen een rechtsgeldig beroep doen op onvolkomenheden, onduidelijkheden, vermeende onrechtmatigheden, tegenstrijdigheden of bezwaren die door uzelf, als <u>individuele zorgaanbieder</u> , uiterlijk 15 juni 2026 12.00 uur aan de orde zijn gesteld.	Tot uiterlijk 15 juni 2026 12.00 uur
4. Publiceren Nota van Inlichtingen a. Hierin worden de gestelde vragen beantwoord en dit leidt de termijn van 20 kalenderdagen in om een kortgedingprocedure te starten.	1 juli 2026*
5. Vervaltermijn starten kortgeding tegen contracteerbeleid incl. NvI a. Dit is een kortgedingprocedure tegen de <u>systematiek</u> van het Zorginkoopbeleid. b. Om een kortgeding te starten, moet de individuele zorgaanbieder bezwaar hebben gemaakt vóór 15 juni 2026. c. Indien er geen kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, dan staat het Zorginkoopbeleid <u>tot en met 2029 vast</u> .	21 juli 2026
6. Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders	Uiterlijk 31 juli 2026 17:00 uur**
7. Bekendmaken uitkomst beoordeling offerte door het zorgkantoor	Uiterlijk 4 september 2026***
8. Vervaltermijn voor bezwaar en kortgeding tegen publicatie van de definitieve vertrektarieven 2027 en voorlopige terugkoppeling a. Dit is een kortgedingprocedure tegen definitieve vertrektarieven 2027 die voortvloeien uit de systematiek van het Zorginkoopbeleid. b. Indien er geen kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, dan staat het definitieve vertrektarief voor 2027 vast.	24 september 2026****
9. Mogelijkheid tot gesprek over contractering en voorwaarden	Uiterlijk 2 oktober 2026 afgerond
10. Definitieve terugkoppeling inschrijving / aanbieden overeenkomst	Uiterlijk 23 oktober 2026
11. Vervaltermijn voor kortgeding tegen definitieve terugkoppeling a. Dit is een kortgedingprocedure tegen de definitieve selectie van zorgaanbieders. Indien u het oneens bent met uw beoordeling, dan kunt u in dit stadium een kortgeding starten. b. Van belang is dat dit <u>geen</u> kortgedingprocedure is tegen de systematiek van het Zorginkoopbeleid noch tegen de definitieve vertrektarieven. Deze staan – tenzij daar eerder een kort geding tegen is gestart – al vast.	6 november 2026
12. Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa	13 november 2026

Let op:

- * Zorgkantoor CZ opent op 1 juli 2026 ook de inschrijvingen.
- ** Op uiterlijk 31 juli 2026 om 17:00 uur dient een inschrijver de regionale maatwerkafspraken in te dienen bij zorgkantoor Zorg en Zekerheid.
- *** Zorgkantoor DSW maakt op 23 oktober 2026 de uitkomst van de beoordeling van de offerte bekend. De planning van DSW wijkt daarmee af van de planning van de overige zorgkantoren. Zilveren Kruis geeft inschrijvers op 28 augustus 2026 een voorlopige terugkoppeling over de uitkomst van de beoordeling van de offerte.
- **** Zorgkantoor Zilveren Kruis bepaalt dat de termijn van 24 september 2026 tevens een vervaltermijn is voor bezwaar en beroep tegen: i) Publicatie van de definitieve vertrektarieven, ii) vervaltermijn voor bezwaar en kortgeding tegen terugkoppeling van de uitkomst van de inschrijving, iii) beroep op de hardheidsclausule. Bovendien stelt het Zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis dat het budgetformulier via het NZa-portaal uiterlijk 30 oktober 2026 moet worden ingediend en de overeenkomst ook op diezelfde datum moet worden ondertekend. Ook zal Zilveren Kruis de ingediende budgetformulieren controleren en doorzetten naar de NZa op 12 november 2026. Op 1 juni 2027 vindt de deadline aanvullende afspraken plaats, waaronder afspraken in het kader van regionale ontwikkeling.

Kortgedingprocedures

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel zijn er drie momenten waarop een kortgedingprocedure kan worden gestart (zie nummers 5, 8 en 11). Wij begrijpen dat dit verwarrend kan zijn. Het is daarom belangrijk om te benadrukken dat deze kort gedingen niet hetzelfde onderwerp hebben en niet hetzelfde effect kunnen bereiken.

1. Eerste kort geding in juli aanstaande: tegen het meerjarige zorginkoopbeleid (2027-2029)

Het eerste kort geding richt zich tegen het zorginkoopbeleid zelf, dat geldt voor een periode van drie jaar. In dit kort geding staat centraal of het beleid als zodanig rechtmatig is, bijvoorbeeld:

- a. of het beleid voldoende duidelijk en voldoende genormeerd is;
- b. of het beleid in overeenstemming is met algemene beginselen zoals transparantie, gelijkheid en evenredigheid; en
- c. of zorgaanbieders op basis van dit beleid kunnen voorzien waar zij de komende jaren aan toe zijn.

Dit kort geding gaat dus niet over concrete vertrektarieven of individuele contracten, maar over de zorginkoop-systematiek en de juridische toelaatbaarheid van het beleidskader dat voor **drie jaar** wordt vastgesteld.

2. Tweede kort geding in september aanstaande: tegen de vaststelling van het tarief voor één jaar (2027)

Het tweede kort geding in september heeft een ander object. Dit kort geding richt zich tegen de concrete vaststelling van het vertrektarief voor het eerstvolgende kalenderjaar. Hier staat niet langer de systematiek of het beleidskader centraal, maar het concrete gevolg van de systematiek en dus de vraag:

- a. of het tarief dat op basis van het zorginkoopbeleid wordt vastgesteld, rechtmatig is;
- b. of het tarief kostendekkend is; en
- c. of het tarief correct en consistent is afgeleid uit het zorginkoopbeleid.

Dit kort geding ziet dus uitsluitend op één jaar (2027), en niet op de rechtmatigheid van het meerjarige Zorginkoopbeleid als zodanig.

3. Derde kort geding in november aanstaande: tegen de individuele contractering voor één jaar (2027)

Het derde kort geding, meestal in november, richt zich op de individuele contractering van zorgaanbieders voor het komende jaar.

In dit kort geding gaat het bijvoorbeeld om:

- a. de inhoud van het individuele contract;
- b. de toegepaste volumes, voorwaarden of beperkingen; en
- c. de vraag of de contractering in overeenstemming is met het beleid en de vastgestelde tarieven.

Ook dit kort geding ziet dus slechts op één kalenderjaar (2027) en op de concrete toepassing van beleid en tarieven op het niveau van de individuele zorgaanbieder.

Rechtsverwerking

Het Zorginkoopbeleid bepaalt dat na publicatie van de NvI in beginsel alleen nog bezwaar kan worden gemaakt tegen onderdelen van het Zorginkoopbeleid die door de NvI zijn *gewijzigd*. Voor onderdelen die *ongewijzigd* blijven, geldt dat deze na dat moment in beginsel vaststaan. Dit betekent dat, indien geen bezwaar wordt gemaakt vóór de NvI, er bij de ongewijzigde onderdelen van het Zorginkoopbeleid sprake is van rechtsverwerking. Met andere woorden: u kunt daar dan niet meer (in rechte) tegenop komen. Of en hoe hiermee wordt omgegaan, is een individuele afweging van iedere zorgaanbieder.

- Als u besluit om geen kortgeding aanhangig te maken in juli 2026, dan kunt u bij een eventueel kort geding in september aanstaande niet meer opkomen tegen de systematiek van het Zorginkoopbeleid. Er is dan sprake van rechtsverwerking. Met andere woorden: u kunt daar dan niet meer (in rechte) tegenop komen en de systematiek staat dan tot en met 2029 vast. Of en hoe hiermee wordt omgegaan, is een individuele afweging van iedere zorgaanbieder.
- Als u besluit om geen kortgeding aanhangig te maken in juli/september aanstaande, dan kunt u bij een eventueel kort geding in november aanstaande niet meer opkomen tegen de systematiek van het Zorginkoopbeleid en ook niet tegen de vertrektarieven. Er is dan sprake van rechtsverwerking. Met andere woorden: u kunt daar dan niet meer (in rechte) tegenop komen. Of en hoe hiermee wordt omgegaan, is een individuele afweging van iedere zorgaanbieder.

Rechtsmiddelen

Indien u op basis van uw eigen beoordeling aanleiding ziet om uw rechtspositie te willen borgen, kunnen in algemene zin de volgende stappen een rol spelen:

1. Vragen stellen via de Nota van Inlichtingen

U kunt vragen stellen over onderdelen van het Zorginkoopbeleid die voor u onduidelijk zijn, bijvoorbeeld over tariefsystematiek, budgetkaders, clustering of andere voorwaarden. **Vragen stellen dient tijdig te geschieden.**

2. Bezwaar maken tegen (onderdelen van) het Zorginkoopbeleid

Daarnaast bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken tegen (delen van) het Zorginkoopbeleid. Dit doet u via het indienen van bezwaar bij het specifieke zorgkantoor (niet via het stellen van vragen via de NvI). Ook hier geldt: dit is een individuele keuze. U bepaalt zelf of u dit doet en hoe u dit vormgeeft. **Bezwaar aantekenen dient tijdig te geschieden.**

3. Combinatie van vragen en bezwaar

Het is mogelijk zowel a) vragen te stellen in het kader van de NvI als b) afzonderlijk bezwaar maken tegen (onderdelen van) het Zorginkoopbeleid. Daarbij kan in een bezwaar worden vermeld dat eerder ingediende vragen als bijlage zijn toegevoegd. Het is aan iedere zorgaanbieder om zelfstandig te beoordelen of hij van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Ter inspiratie voegen wij een concept voorbeeld van een bezwaarbrief bij. Dit document is volledig vrijblijvend en niet bedoeld als advies. U beslist te allen tijde zelf:

- of en hoe u bezwaar maakt;
- of en hoe u dit voorbeeld gebruikt;
- en hoe u een eventueel bezwaar aanpast aan uw eigen situatie.

Deze voorbeeld-bezwaarbrieven vindt u aan het einde van dit document.

Voorbeeldvragen

Let op: Onderstaande vragen zijn slechts een kapstok om te gebruiken bij de formulering van uw vragen en geenszins sturend van aard. Van belang is dat u de vragen toespitst op de voor u toepasselijke situatie en deze dan ook voldoende specificeert. Wanneer van belang kunt u van deze voorbeeldvragen ook bezwaren maken. Daarnaast uiteraard ook van belang nog andere vragen te stellen indien daartoe aanleiding is. Zorg ervoor dat u vragen formuleert en maak daarbij uw eigen afweging, zonder afstemming met andere aanbieders.

Vragen over landelijk beleid

I. Vragen over Landelijk Beleidskaders Wlz 2027 (ZN)

Vraag	Paragraaf
In het landelijk beleidskader Wlz 2027 dat is gepubliceerd door ZN staan veel onderwerpen die ook (op het oog) geheel of gedeeltelijk worden geregeld in het Inkoopbeleid van de zorgkantoren. In de rangorde komt (de inhoudelijke uitwerking van) het landelijk beleidskader na de Getekende overeenkomst Wlz 2027, de meest recente Nota's van inlichtingen en het Inkoopbeleid Wlz 2027-2029 van het zorgkantoor. Klopt dat? Zo nee, graag een toelichting.	1
U stelt: "Wij verwachten dat elke regio het convenant MGZ implementeert door aan de daarvoor bestemde regiotafels afspraken te maken." Met deze passage gaan wij ervanuit dat zorgkantoren 'daarbij passende inkoopafspraken bedoelen'. Kunt u dat bevestigen? Zo nee, waarom niet?	2.1
U stelt: "Wij verwachten dat elke regio het convenant MGZ implementeert door aan de daarvoor bestemde regiotafels afspraken te maken." Bent u het met ons eens dat zorgverzekeraars daarbij ook passende afspraken moeten maken met de huisartsen in kwestie. Zo nee, waarom niet?	2.1
U beschrijft dat hoe het zorgkantoor met het verzoek omgaat, afhankelijk is van regionaal beleid en van de beschikbare contracteerruimte. Wij zijn echter van mening dat de contracteerruimte niet mag voortgaan op de behoefte van de cliënt. Hoe waarborgt u dat er voldoende budget beschikbaar is voor het bieden van behandeling aan cliënten voor wie dit noodzakelijk is?	2.1

In de aanvullende inkoopvoorwaarden stelt u dat elke zorgaanbieders MGZ conform het convenant voor het cliënten georganiseerd dient te hebben, ongeacht de leveringsvorm. Wij menen dat er geen MGZ-samenwerking nodig is, indien je als aanbieder voor alle cliënten verblijf en behandeling biedt. Een uitzondering hierop is de HAP, afhankelijk van hoe dit georganiseerd is. Wij stellen voor dit te verwerken in deze passage. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	2.1
Elke zorgaanbieder organiseert de MGZ voor haar cliënten conform het convenant, ongeacht de leveringsvorm, en zet de beschikbare SO/AVG-capaciteit regionaal in volgens de daarover gemaakte afspraken. Wij menen dat deze werkwijze alleen goed uitvoerbaar is als regionale samenwerkingspartners hierover overeenstemming bereiken. Als die overeenstemming uitblijft, ligt het volgens ons voor de hand dat het zorgkantoor een regiotafel bijeenroept om tot een oplossing te komen. Sluit het zorgkantoor zich hierbij aan? Zo nee, waarom niet?	2.1
In het beleid beschrijft u: "H335/ H336 kan ook afgesproken worden voor de inzet PA/ VS mits er aantoonbare, ondertekende, afspraken zijn tussen zorgaanbieder HA - SO/ AVG." Deze zin vinden wij verwarrend, aangezien taakdelegatie en taakherschikking geen deel uitmaken van de afspraken MGZ. Deze worden binnen de eigen praktijkorganisatie afgesproken. Wij stellen daarom voor om de laatste zin te wijzigen dan wel te verwijderen. Stemt het zorgkantoor in met deze aanpassing? Zo nee, waarom niet?	2.1
De Mondzorg is ook in de Aanvullende inkoopvoorwaarden Wlz 2026 uitgebreid geregeld. De zorgaanbieders hebben dus al veel geïmplementeerd. Klopt het dat de aanvullende inkoopvoorwaarden in paragraaf 2.2 van het Landelijk beleidskader Wlz 2027 alleen betrekking hebben op het onderdeel Machtigingen en vergoedingen? Zo nee, waar zijn de aanvullende voorwaarden in 2027 dan nog meer gewijzigd ten opzichte van 2026?	2.2
Kunt u toelichten op welke wijze bij de totstandkoming van dit beleidskader is beoordeeld of de aanvullende administratieve verplichtingen proportioneel en uitvoerbaar zijn voor zorgaanbieders en mondzorgprofessionals?	2.2
De combinatie van onderaannemersregistratie, schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten, dubbele dossiervoering, AO/IC, audits en declaratiecontrole kan voor instellingen behoorlijk zwaar worden. Vooral omdat mondzorg vaak relatief kleinschalig is binnen de totale zorgverlening. Kunt u toelichten hoe de proportionaliteit van de aanvullende administratieve verplichtingen rondom mondzorg is beoordeeld, mede gelet op de omvang van de mondzorgactiviteiten binnen instellingen, bestaande kwaliteits- en verantwoordingskaders en de beschikbare personele capaciteit?	2.2

De combinatie van onderaannemersregistratie, schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten, dubbele dossiervoering, AO/IC, audits en declaratiecontrole kan voor instellingen behoorlijk zwaar worden. Vooral omdat mondzorg vaak relatief kleinschalig is binnen de totale zorgverlening. Welke stappen onderneemt u in dit kader om de administratieve uitvoeringslasten te beperken?	2.2
De combinatie van onderaannemersregistratie, schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten, dubbele dossiervoering, AO/IC, audits en declaratiecontrole kan voor instellingen behoorlijk zwaar worden. Vooral omdat mondzorg vaak relatief kleinschalig is binnen de totale zorgverlening. Wordt in dat kader overwogen om landelijke standaardformats of modeldocumenten beschikbaar te stellen teneinde administratieve lasten te beperken?	2.2
Kunt u verduidelijken hoe de verantwoordelijkheid van de Wlz-zorgaanbieder voor toezicht op mondzorgdeclaraties en "passende zorg" zich verhoudt tot de professionele autonomie van de mondzorgprofessional, diens zelfstandige behandelverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheidsverdeling vanuit de Wet BIG en WGBO?	2.2
Kunt u nader verduidelijken hoe de afbakening tussen "dagelijkse mondverzorging" en "professionele mondzorg" in de praktijk moet worden toegepast, met name bij preventieve handelingen die worden uitgevoerd door preventie-assistenten binnen intramurale settingen?	2.2
U schrijft op blz. 7 dat de zorgaanbieder "controleert dat de mondzorgprofessional niet meer tijd of andere of meer prestaties declareert bij het zorgkantoor dan daadwerkelijk geleverd. De zorgaanbieder heeft zijn AO/IC hierop aangepast." Hoe verwacht u dat een zorgaanbieder deze controle effectief en zinnig uitvoert als de mondzorgprofessional direct bij het zorgkantoor declareert? Zorgaanbieders beschikken immers niet over de brongegevens om dit te doen.	2.2
Het beleid en de aanvullende voorwaarden met betrekking tot hulpmiddelen en roerende voorzieningen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3 van het Landelijk beleidskader Wlz 2027, is identiek aan het beleid en de voorwaarden zoals opgenomen in de Aanvullende inkoopvoorwaarden Wlz 2026. Klopt dat? Zo nee, welke wijzigingen zijn er dan in 2027 ten opzichte van 2026?	2.3
Het beleid met betrekking tot chronische ademhalingsondersteuning, zoals opgenomen in paragraaf 2.4 is toegevoegd ten opzichte van 2026. De aanvullende voorwaarden, die zijn opgenomen zijn identiek aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Aanvullende inkoopvoorwaarden Wlz 2026. Klopt het dat alleen het beleid met betrekking tot chronische ademhalingsondersteuning is gewijzigd? Zo nee, welke wijzigingen zijn er dan in 2027 ten opzichte van 2026?	2.4
Het beleid met betrekking tot infectiepreventie, zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van het Landelijk beleidskader Wlz 2027 is identiek aan het beleid zoals opgenomen in de Aanvullende inkoopvoorwaarden Wlz 2026.	2.5

Klopt dat? Zo nee, welke wijzigingen zijn er dan in 2027 ten opzichte van 2026?	
Op blz. 10 somt u de LVHC doelgroepen op. Wij constateren dat deze opsomming niet compleet is. Wij missen de doelgroep Syndroom van Korsakov en de doelgroep Kind & NAH. Uit de overige tekst maken wij op dat deze doelgroepen wel onderdeel maken van het beleid in deze paragraaf. Zij behoren immers tot het doelgroepen netwerk binnen de lvhc-structuur zoals commissie CEIz die beschrijft. Wij verzoeken het zorgkantoor deze doelgroepen toe te voegen. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	2.6
U schrijft dat u verwacht dat zorgaanbieders per 1 januari 2028 is gecertificeerd voor minimaal niveau brons en per 1 januari 2030 is gecertificeerd voor minimaal niveau zilver. Certificering van de Milieuthermometer Zorg vindt echter niet op organisatieniveau plaats, maar per locatie. Is het voor zorgaanbieders met meerdere locaties voldoende dat per 1 januari 2028 minimaal één locatie is gecertificeerd voor minimaal niveau brons en per 1 januari 2030 minimaal één locatie is gecertificeerd voor minimaal niveau zilver? Zo nee, waarom niet?	2.7
U schrijft dat er ook alternatieve manieren zijn om duurzaamheid aantoonbaar te maken. Deze staan in de "Handleiding aantoonbare duurzaamheid en duurzaamheidscertificering in de Zorginkoop". Eén daarvan is het invullen van een checklist. Hoe toetst u in dat geval de voortgang tussen 1-1-2028 en 1-1-2030? Worden er in toekomstige checklists andere vragen gesteld en indirect een hogere norm gesteld?	2.7
"En in het bijzonder ... 2030 t.o.v. 2018. Middels deze passage stellen zorgkantoren één doel uit de Green Deal centraal, terwijl het onzes inziens van belang is om de doelstellingen in zijn volledigheid te belichten. Waarom kiest het zorgkantoor ervoor deze doelstelling centraal te stellen? In de praktijk zien we dat de doelstelling rondom het verminderen van het gebruik van incontinentiemateriaal zeer lastig te bereiken is. De zorgvraag en daarmee ook de incontinentie van de cliënt neemt immers steeds verder toe. Bovendien zijn de opties op het gebied van duurzame incontinentiezorg (recycling, wasbaar, etc.) op dit moment nog zeer beperkt. Heeft u hier rekening mee gehouden? Kunt u ermee instemmen dat een inspanningsverplichting op deze doelstelling voldoende is? Zo nee, waarom niet?	2.7
"We gaan zorgaanbieders ...doelen van de GDDZ. Zorgkantoren spreken een duidelijke voorkeur uit voor het gebruik van de Milieu Thermometer Zorg ten opzichte van andere manieren om duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk te maken. Aanbieders ontvangen ook alleen een vergoeding bij het gebruik van de Milieu Thermometer Zorg. Wij zijn van mening dat zorgkantoren hiermee een middel centraal stellen, in plaats van het doel om te verduurzamen. Wij verzoeken zorgkantoren daarom om ook aanbieders die hun duurzaamheidsinspanning op andere manieren inzichtelijk maken een vergoeding te bieden? Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	2.7

U eist dat zorgaanbieders hun zorg- en vastgoedexploitatie separaat inzichtelijk maken. Met welk oogmerk wordt deze eis gesteld en hoe is de noodzaak en de proportionaliteit ervan beoordeeld?	2.8
U eist dat zorgaanbieders hun zorg- en vastgoedexploitatie separaat inzichtelijk maken. Is de zorgorganisatie vrij in het kiezen van een methode om kosten toe te rekenen?	2.8
Hoe verhouden de geformuleerde inkoopvoorwaarden zich tot de eigen integrale verantwoordelijkheid van zorgaanbieders?	2.8
U stelt: "Zorgaanbieders informeren en, waar nodig, betrekken zorgkantoren bij keuzes over vastgoed, gezien de impact hiervan op de beschikbaarheid van passend vastgoed in de regio." Kunt u nader omschrijven wie bepaalt waar dit nodig is, hoe dit besproken wordt in de regio en welke rol het zorgkantoor heeft bij het betrekken van deze keuzes? Vanuit de eigen verantwoordelijkheid die een zorgaanbieder heeft over zijn zorgvastgoed en beleid en keuzes daar omtrent, kan het zorgkantoor slechts adviserend zijn.	2.8
Wat doet het zorgkantoor met het opgevraagde en verstrekte plan op het gebied van zorgvastgoed en op welke wijze wordt dit plan gebruikt in het verdere inkoop- en toezicht proces?	2.8
U stelt: "we gaan op brancheniveau in gesprek over de manier waarop dit kan worden vormgegeven" Kunt u nader toelichten welke verwachtingen het zorgkantoor heeft bij deze gesprekken op brancheniveau?	2.8
Zorgkantoren hanteren verschillende verwachtingen richting Wlz-aanbieders met betrekking tot MGZ. Deze afspraken zijn echter noodzakelijkerwijs ook afhankelijk van de samenwerkingspartners (huisartsen en inkoopende partijen). Wij verzoeken het zorgkantoor deze randvoorwaarde mee te nemen in haar verwachtingen richting zorgaanbieders. Bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?	3.1
In paragraaf 3.2 van het Landelijk beleidskader Wlz 2027 staat dat het toetsingskader geldt als een eerste uitwerking en op basis van de toepassing in de praktijk kan worden bijgesteld. In voetnoot 5 staat: "Eventuele aanpassingen worden jaarlijks op 1 juni tegelijkertijd met ander aanvullend beleid gepubliceerd." De vraag is of eventuele aanpassingen dan ook pas op 1 januari van het jaar volgend op publicatie worden toegepast of dat de aanpassingen dan al op 1 juli volgend op de datum van publicatie kunnen worden toegepast. Het lijkt ons niet wenselijk als wordt geconcludeerd dat aanpassingen gewenst zijn, dat het dan nog 7 maanden duurt voor ze van toepassing zijn. Wij gaan ervanuit dat aanpassingen die worden gepubliceerd op 1 juni van enig	3.2

jaar op 1 juli van datzelfde jaar ingaan. Klopt dat? Zo nee, graag een toelichting.	
In de voetnoot op blz. 20 definieert u geclusterde zorg als volgt "Wij spreken van geclusterde zorg als drie of meer mensen met dezelfde postcode (PC6 niveau) zorg ontvangen." Past u deze definitie één op één en in alle gevallen toe? Zo nee, waarom niet? Wij stellen deze vraag, omdat u in de landelijke Regiomonitor 2026 verpleegzorg dezelfde definitie gebruikt, maar vervolgens stelt "Indien drie of meer klanten op een PC6 wonen, maar door controle is bepaald dat dit geen geclusterde woonvorm betreft, zijn klanten geteld als ongeclusterd VPT." Die tekst impliceert dat u nog een andere definitie hanteert. Indien dat zo is, welke is dat dan?	3.2
Op blz. 21 bovenaan schrijft u: "Als de structurele inzet van de bovenstaande aspecten niet rendabel te organiseren zijn vanuit een mpt, terwijl deze wél leiden tot een aantoonbaar lagere personele inzet of tot betere ondersteuning kan een vpt passend zijn." Wat bedoelt u met "niet rendabel"? Dat het niet past binnen de MPT-tarieven of binnen het MPT-budget, of iets anders?	3.2
Op blz. 21 schrijft u: "Het basisuitgangspunt is te allen tijde: De kosten op cliëtniveau moeten te allen tijde in redelijke verhouding staan tot de inkomsten. Het uitgangspunt hierbij is dat wanneer de kosten minder dan 80% van de inkomsten bij inzet vpt bedragen, het mpt altijd de best passende leveringsvorm is."	3.2
Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich met de inhoudelijke criteria in dit toetsingskader? Vindt u een financiële afweging belangrijker dan een inhoudelijke afweging? Zo ja, kunt u dit onderbouwen?	
Op blz. 21 schrijft u: "Het basisuitgangspunt is te allen tijde: De kosten op cliëtniveau moeten te allen tijde in redelijke verhouding staan tot de inkomsten. Het uitgangspunt hierbij is dat wanneer de kosten minder dan 80% van de inkomsten bij inzet VPT bedragen, het MPT altijd de best passende leveringsvorm is."	3.2
Hoe moeten we het begrip 'kosten' in deze passage interpreteren en stelt het zorgkantoor een hulpmiddel beschikbaar om deze kosten te berekenen?	
Kan het zorgkantoor precies beschrijven wat bedoeld wordt met 'inkomsten inzet VPT'?	3.2
Kunt u toelichten waarom u nieuw beleid ontwikkelt voor ongeclusterde VPT, maar niet voor geclusterde VPT? Welke overwegingen liggen ten grondslag aan dit onderscheid? En waarom acht u het gerechtvaardigd om deze twee vormen van VPT beleidsmatig verschillend te behandelen?	3.2
Op blz. 21 schrijft u: "Het basisuitgangspunt is te allen tijde: De kosten op cliëtniveau moeten te allen tijde in redelijke verhouding staan tot de inkomsten. Het uitgangspunt hierbij is dat wanneer de kosten minder dan 80% van de inkomsten bij inzet vpt bedragen, het mpt altijd de best passende leveringsvorm is." Kunt u het onderzoek delen dat aan deze 80%-norm ten grondslag ligt?	3.2

Wij ervaren de regelgeving en administratieve vereisten rondom MPT als aanzienlijk complexer en belastender dan die voor VPT. Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om de administratieve belasting binnen het MPT te verminderen en de uitvoering hiervan te vereenvoudigen?	3.2
Bent u het ermee eens dat zorgaanbieders vanaf 2027 voor cliënten met een MPT de uitgangspunten kunnen hanteren die door Zorgkantoor DSW worden toegepast binnen de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dit zou betekenen dat uitsluitend een AAT wordt ingediend wanneer een nieuwe zorgaanbieder bij de zorgverlening wordt betrokken, wanneer de leveringsvorm wijzigt of wanneer de zorg niet langer verantwoord kan worden geleverd. Indien u hiermee niet instemt, kunt u dan toelichten op welke gronden en welke bezwaren daaraan ten grondslag liggen?	3.2
Binnen het VPT hebben wij de mogelijkheid om medewerkers in te zetten voor activiteiten die bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van cliënten, waaronder: • het ondersteunen van het netwerk van de cliënt, zoals mantelzorgers en andere vormen van informele zorg; • het ondersteunen van de cliënt bij het onderhouden en versterken van dit netwerk; • zorgcoördinatie en zorgregie; • activiteiten gericht op welzijn en welbevinden. Deze werkzaamheden zijn naar onze ervaring essentieel om cliënten op verantwoorde wijze langer thuis te laten wonen en om zwaardere zorgvragen of opname uit te stellen. Kunt u aangeven op welke wijze deze en vergelijkbare activiteiten binnen het MPT kunnen worden aangeboden, geregistreerd en gedeclareerd? Bent u van mening dat hiervoor de prestatie Begeleiding (NZa-prestatiecode H300) kan worden gebruikt? Indien dit niet mogelijk is, kunt u toelichten waarom niet en aangeven welke prestatie(s) dan wel geschikt zijn voor de registratie en declaratie van deze activiteiten?	3.2
"Het basisuitgangspunt is ... passende leveringsvorm is." Naar onze mening doet deze algemene voorwaarden de eerdergenoemde criteria teniet. Dit criterium zou nevensgeschikt moeten zijn en niet bovengeschild aan de overige criteria. Het moet een aanvulling zijn op het vierde criterium. Er kan sprake zijn van cliënten die tegen de 80% grens aanzitten, maar ook een complexe instabiele zorgvraag hebben met hoge administratieve lasten. Dit kan ongewenste grensgevallen opleveren waarin doelmatigheid boven zorginhoudelijke argumenten gaat. Wij verzoeken om het 80% criterium niet bovengeschild te maken, maar toe te voegen aan criterium vier. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	3.2
"Zorgkantoren gaan ervan ...verzilveren via een mpt." Hoewel wij begrijpen dat zorgkantoren een streefnorm willen hanteren, willen wij erop wijzen dat het toetsingskader primair bedoeld is om aanbieders de ruimte te bieden een VPT in te zetten wanneer dit, onder	3.2

de gestelde voorwaarden, beter aansluit bij de situatie en behoeften van de cliënt dan een MPT. Wij zien het risico dat een streefnorm van 90% deze beoogde ruimte in de praktijk beperkt. Kunt u toelichten hoe wordt geborgd dat de individuele situatie en ondersteuningsbehoefte van de cliënt leidend blijven bij de keuze tussen VPT en MPT, en niet de streefnorm zelf?	
"In het Hoofdlijnen ... criteria passender is." Een van de voorwaarden die in het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg is overeengekomen, betreft het beperken van de administratieve lasten die samenhangen met het modulair pakket thuis. Kunt u toelichten op welke wijze en wanneer u helderheid gaat verschaffen over hoe u deze administratieve lasten beperkt?	3.2
"Het vergroten van ...en zij instroom)." Bent u van mening dat onder het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers ook inspanningen met betrekking tot het begeleiden van BOL- en BBL-leerlingen kunnen vallen? Zo nee, waarom niet?	3.3
"Het vergroten van ...en zij instroom)" Kunt u verduidelijken of de regeling voor BOL- en BBL-leerlingen ook van toepassing is op hbo- en hbo-duaal studenten? Zo nee, kunt u toelichten waarom hiervoor is gekozen, gelet op het belang van een juiste deskundigheidsmix met verschillende deskundigheidsniveaus? Deze leerlingen of stagiairs vragen ook begeleidingstijd van een organisatie.	3.3
Op welke wijze proberen zorgkantoren de administratieve lasten rondom het aanvragen van het regiobudget HLO te beperken?	3.3
In de aanvullende inkoopvoorwaarden voor het Regiobudget HLO lezen wij dat de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor het regiobudget is vastgesteld op 1 juli. Kunt u bevestigen of hiermee wordt bedoeld op 1 juli 2026 of 1 juli 2027? Indien sprake is van 1 juli 2026, merken wij op dat deze termijn naar onze mening zeer kort is. Het lijkt onrealistisch om van aanbieders te verwachten dat zij binnen vier weken na publicatie van het inkoopbeleid een volledig afgestemde aanvraag kunnen voorbereiden en indienen. Wij verzoeken u daarom te bevestigen welke datum van toepassing is. Mocht 1 juli 2026 inderdaad de beoogde deadline zijn, dan verzoeken wij u de indieningstermijn met ten minste vier weken te verlengen. Stemt het zorgkantoor hiermee in? Zo nee, waarom niet?	3.3
Het beleid met betrekking tot herstelgerichte behandeling, zoals opgenomen in paragraaf 3.4 van het Landelijk beleidskader Wlz 2027 is identiek aan het beleid zoals opgenomen in de Aanvullende inkoopvoorwaarden Wlz 2026. Klopt dat? Zo nee, welke wijzigingen zijn er dan in 2027 ten opzichte van 2026?	3.4

II. Vragen bij Overeenkomst Wlz 2027-2029

Vraag	Paragraaf
Kan worden toegelicht op welke wijze bij de totstandkoming van dit beleidskader is beoordeeld of de aanvullende administratieve verplichtingen proportioneel en uitvoerbaar zijn voor zorgaanbieders en mondzorgprofessionals?	Hfst. 1, art. 2, lid 1
Het beleidskader vereist dat de door de mondzorgprofessional geleverde zorg wordt vastgelegd in zowel het cliëntdossier van de Wlz-zorgaanbieder als dat van de mondzorgprofessional. Er is zagezegd sprake van dubbele dossiervoering.	Hst 1, art. 2, lid 9
Kan het zorgkantoor verduidelijken welke minimale gegevens in beide dossiers aanwezig moeten zijn?	
Het beleidskader vereist dat de door de mondzorgprofessional geleverde zorg wordt vastgelegd in zowel het cliëntdossier van de Wlz-zorgaanbieder als dat van de mondzorgprofessional. Er is zagezegd sprake van dubbele dossiervoering.	Hfst. 1, art. 2, lid 9
Kan het zorgkantoor verduidelijken of koppelingen of samenvattingen hierin volstaan?	
Het beleidskader vereist dat de door de mondzorgprofessional geleverde zorg wordt vastgelegd in zowel het cliëntdossier van de Wlz-zorgaanbieder als dat van de mondzorgprofessional. Er is zagezegd sprake van dubbele dossiervoering.	Hfst. 1, art. 2, lid 9
Kan worden verduidelijkt hoe het zorgkantoor poogt onnodige dubbele administratieve lasten te voorkomen?	
Met betrekking tot de controleplicht die bij zorgaanbieders wordt neergelegd op het gebied van tijdsbesteding, prestaties en rechtmatigheid van declaraties van mondzorgprofessionals signaleren wij dat veel instellingen geen tandheelkundige expertise hebben, evenals meestal geen inzage in de behandelinhoud en geen capaciteit voor detailcontrole.	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Kan het zorgkantoor verduidelijken welke concrete controlewerkzaamheden van zorgaanbieders worden verwacht ten aanzien van door mondzorgprofessionals gedeclareerde prestaties en tijdsbesteding?	
Met betrekking tot de controleplicht die bij zorgaanbieders wordt neergelegd op het gebied van tijdsbesteding, prestaties en rechtmatigheid van declaraties van mondzorgprofessionals signaleren wij dat veel instellingen geen tandheelkundige expertise hebben, evenals meestal geen inzage in de behandelinhoud en geen capaciteit voor detailcontrole.	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Kan het zorgkantoor verduidelijken welke mate van inhoudelijke toetsing redelijkerwijs van zorgaanbieders verwacht wordt?	
Met betrekking tot de controleplicht die bij zorgaanbieders wordt neergelegd op het gebied van tijdsbesteding, prestaties en rechtmatigheid van declaraties van mondzorgprofessionals signaleren wij dat veel instellingen geen tandheelkundige expertise hebben, evenals meestal geen inzage in de behandelinhoud en geen capaciteit voor detailcontrole.	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Kan het zorgkantoor verduidelijken hoe dit zich verhoudt tot de eigen verantwoordelijkheid van de mondzorgprofessional?	

Met betrekking tot de controleplicht die bij zorgaanbieders wordt neergelegd op het gebied van tijdsbesteding, prestaties en rechtmatigheid van declaraties van mondzorgprofessionals signaleren wij dat veel instellingen geen tandheelkundige expertise hebben, evenals meestal geen inzage in de behandelinhoud en geen capaciteit voor detailcontrole. Kan worden verduidelijkt op basis van welke norm het zorgkantoor beoordeelt of de zorgaanbieder "voldoende toezicht" heeft gehouden? Welke mate van detailcontrole is volgens het zorgkantoor proportioneel?	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Het beleidskader stelt dat de zorgaanbieder de AO/IC moet aanpassen ten aanzien van mondzorgdeclaraties. Kan het zorgkantoor verduidelijken welke minimale eisen aan de AO/IC worden gesteld?	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Het beleidskader stelt dat de zorgaanbieder de AO/IC moet aanpassen ten aanzien van mondzorgdeclaraties. Kan het zorgkantoor verduidelijken of hiervoor landelijke richtlijnen beschikbaar komen?	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Het beleidskader stelt dat de zorgaanbieder de AO/IC moet aanpassen ten aanzien van mondzorgdeclaraties. Kan het zorgkantoor verduidelijken hoe proportionaliteit wordt gewaarborgd voor kleinere zorgaanbieders?	Hfst. 1, art. 2, lid 10
Zorgaanbieders worden verplicht om minimaal jaarlijks interne audits uit te voeren op de kwaliteit van mondzorg. Kan het zorgkantoor verduidelijken welke concrete eisen aan deze audits worden gesteld?	Hfst. 1, art. 2, lid 12
Zorgaanbieders worden verplicht om minimaal jaarlijks interne audits uit te voeren op de kwaliteit van mondzorg. Kan het zorgkantoor verduidelijken of bestaande kwaliteits- en auditcycli hiervoor gebruikt mogen worden?	Hfst. 1, art. 2, lid 12
Zorgaanbieders worden verplicht om minimaal jaarlijks interne audits uit te voeren op de kwaliteit van mondzorg. Kan het zorgkantoor verduidelijken of een afzonderlijke mondzorgaudit verplicht is?	Hfst. 1, art. 2, lid 12
"Het is de zorgaanbieder ... kennis en kunde." Wij veronderstellen dat het zorgkantoor hiermee doelt op de EVC-certificaten (Erkenning Verworven Competenties) in plaats van ECV. Kunt u dit bevestigen?	Hfst. 3
De voorgestelde toelichting ("De zorgaanbieder dient na te gaan of zorgverleners beschikken over de vereiste kennis en kunde") is een herformulering van deze vergewisplicht en voegt daarmee geen inhoudelijke verrijking toe. Dit leidt tot herhaling. Daarnaast geldt de vergewisplicht al voor alle (nieuwe) medewerkers. In de VVT komen EVC-trajecten bovendien nauwelijks voor, waardoor de verwijzing hier niet goed aansluit bij de praktijk. Kunt u toelichten waarom deze aanvulling is opgenomen en wat de aanleiding is om dit expliciet te benadrukken? Is deze toevoeging gebaseerd op een specifieke risico-inschatting of beleidsmatige overweging, of kan dit weg worden gelaten om de tekst algemener en praktijkgericht te houden?	Hfst. 3

"De zorgaanbieder is ... actueel te houden. In deze passage heeft u 'per locatie' toegevoegd. Kunt u toelichten waarom u deze toevoeging heeft gedaan?	Hfst. 3
U stelt: Publicatie(s) over gevoelige situaties die de reputatie van de zorgaanbieder, het zorgkantoor en/of de zorg in het algemeen kunnen schaden, op zo kort mogelijke termijn, en in ieder geval ruim vóór de geplande publicatiedatum. Is het juist dat deze verplichting enkel toeziet op de publicaties die de zorgaanbieder uitbrengt? (op uitingen in de pers kan de zorgorganisatie immers geen regie voeren)	Hfst. 2
Wat is de concrete planning voor de aansluiting van zorgaanbieders op het iWlz-netwerkmodel, inclusief de belangrijkste mijlpalen, afhankelijkheden en aansluitmomenten per zorgaanbieder, zorgkantoorregio en/of leverancier?	Hfst. 3
Geldt voor de overgang naar het iWlz-netwerkmodel één landelijk uniform migratiepad, of kan de overgang verschillen per zorgkantoorregio, leverancier of zorgaanbieder? Hoe wordt daarbij rekening gehouden met zorgorganisaties die in meerdere regio's actief zijn?	Hfst. 3
Welke administratieve, technische, organisatorische en financiële impact wordt voor zorgaanbieders verwacht tijdens de overgangsperiode van iWlz-berichtenverkeer naar het netwerkmodel, waaronder implementatie, opleiding, applicatiebeheer, controlewerkzaamheden en eventuele extra inzet van zorgadministratie?	Hfst. 3
Hebben de zorgkantoren de relevante softwareleveranciers geïnformeerd en betrokken en wanneer wordt duidelijk of zij tijdig werkende software kunnen leveren waarmee zorgaanbieders aan de verplichtingen in de overeenkomst kunnen voldoen?	Hfst. 3
Welke afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van softwareaanpassingen, implementatie, beheer en ondersteuning? Wordt voorzien dat deze kosten door leveranciers worden doorberekend aan zorgaanbieders, of zijn hierover landelijke afspraken of compensatiemogelijkheden voorzien?	Hfst. 3
Welke afspraken gelden als een zorgaanbieder door afhankelijkheid van de eigen softwareleverancier, Silvester of andere landelijke voorzieningen nog niet tijdig kan aansluiten op het netwerkmodel? Kan het zorgkantoor bevestigen dat registratie in registers pas geldt zodra aansluiting technisch, organisatorisch en via de eigen leverancier daadwerkelijk mogelijk is?	Hfst. 3
Artikel 1 van deze overeenkomst verplicht ertoe dat zorg wordt geleverd op basis van wensen en behoeften van klanten met inachtneming en passend binnen de kaders van de indicatie. De administratieve verplichtingen moeten aansluiten bij deze definitie. Wilt u met het oog op consistentie en coherentie art 13 lid 2 zodanig aanpassen dat die aansluit bij de definitie van artikel 1? Zo nee, waarom niet?	Hfst. 4, art. 13, lid 2
U stelt: Betalingen voor zorg waarbij de zorgaanbieder niet aan het tweede lid voldoet, moeten door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor terug worden betaald. Het zorgkantoor heeft de mogelijkheid ten onrechte gedane betalingen gedurende de duur van de overeenkomst of	Hfst. 4, art. 13, lid 3

gedaan in enig voorafgaand jaar te verrekenen bij de herschikking of bij de nacalculatie. Hoe wordt de zorgaanbieder hierover geïnformeerd?	
U stelt: Betalingen voor zorg waarbij de zorgaanbieder niet aan het tweede lid voldoet, moeten door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor terug worden betaald. Het zorgkantoor heeft de mogelijkheid ten onrechte gedane betalingen gedurende de duur van de overeenkomst of gedaan in enig voorafgaand jaar te verrekenen bij de herschikking of bij de nacalculatie. Wordt de zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld bezwaar aan te tekenen?	Hfst. 4, art. 13, lid 3
U stelt: Betalingen voor zorg waarbij de zorgaanbieder niet aan het tweede lid voldoet, moeten door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor terug worden betaald. Het zorgkantoor heeft de mogelijkheid ten onrechte gedane betalingen gedurende de duur van de overeenkomst of gedaan in enig voorafgaand jaar te verrekenen bij de herschikking of bij de nacalculatie. Welke verjaringstermijn hanteert het zorgkantoor voor deze vorderingen?	Hfst. 4, art. 13, lid 3
Op grond van een uitgevoerde (materiële) controle is het zorgkantoor gerechtigd om correcties aan de zorgaanbieder op te leggen teneinde onterecht aan de zorgaanbieder uitgekeerde zorggelden terug te vorderen. Deze correcties worden in beginsel verwerkt in de nacalculatie van het betreffende jaar waarop de controle is uitgevoerd. Hoe wordt de zorgaanbieder hierover geïnformeerd?	Hfst. 4, art. 13, lid 4
Op grond van een uitgevoerde (materiële) controle is het zorgkantoor gerechtigd om correcties aan de zorgaanbieder op te leggen teneinde onterecht aan de zorgaanbieder uitgekeerde zorggelden terug te vorderen. Deze correcties worden in beginsel verwerkt in de nacalculatie van het betreffende jaar waarop de controle is uitgevoerd. Wordt de zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld bezwaar aan te tekenen?	Hfst. 4, art. 13, lid 4
Op grond van een uitgevoerde (materiële) controle is het zorgkantoor gerechtigd om correcties aan de zorgaanbieder op te leggen teneinde onterecht aan de zorgaanbieder uitgekeerde zorggelden terug te vorderen. Deze correcties worden in beginsel verwerkt in de nacalculatie van het betreffende jaar waarop de controle is uitgevoerd. Welke verjaringstermijn hanteert het zorgkantoor voor deze vorderingen?	Hfst. 4, art. 13, lid 4

III. Vragen over Onderbouwing vertrektarieven Wlz 2027

Vraag	Paragraaf
Voor de bepaling van de vertrektarieven maken zorgkantoren uitsluitend gebruik van de jaarrekeningen van jaar t-2. Het betrekken van meerdere jaren zou leiden tot een minder grillige systematiek en daarmee tot meer financiële stabiliteit en voorspelbaarheid voor aanbieders. Kunt u toelichten waarom ervoor is gekozen om uitsluitend jaar t-2 als basis te hanteren? Zijn zorgkantoren bereid om in de systematiek ook de jaarrekeningen van t-3 en t-4 op te nemen? Zo nee waarom niet?	Hfst. 1

Kunt u toelichten waarom gegevens uit jaar t 2 beslissend worden geacht zowel voor de clusterindeling van zorgaanbieders als voor de daarop gebaseerde tariefvorming, en waarom het zorgkantoor deze dubbele beslissende rol van één historisch jaar passend acht bij een zorginkoopbeleid met een looptijd van drie jaren?	Hfst. 1
Kunt u toelichten op basis van welke analyse is vastgesteld dat gegevens uit t-2 een representatief beeld geven van de kostenstructuur van zorgaanbieders gedurende volledige looptijd van het Zorginkoopbeleid, gelet op het feit dat clusterindeling en tariefuitkomst voor die gehele periode worden vastgezet?	Hfst. 1
Welke alternatieve referentieperiodes (bijvoorbeeld meerdere historische jaren) zijn overwogen bij het ontwerp van het tariefmodel, en op grond van welke overwegingen is ervoor gekozen deze alternatieven niet toe te passen, ondanks het meerjarige karakter van het zorginkoopbeleid?	Hfst. 1
Bij de onderbouwing van de richttariefpercentages gaat u ervan uit dat 75% van de aanbieders een neutrale of positief resultaat bereikt. Wij menen dat met het bereiken van een neutraal resultaat geen sprake is van een reëel tarief, immers voor een gezonde bedrijfsvoering is een zeker resultaat onontbeerlijk. Bent u bereid om het richttariefpercentage aan te passen waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat zorgaanbieders een positief resultaat behalen. Zo nee, waarom niet? Hoe ziet u dan de mogelijkheden van zorgaanbieders om risico's op te vangen?	Hfst. 2, deel 3
Kunt u concreet benoemen op basis van welke analyse(s) is vastgesteld dat bij een aandeel van 85% VPT omzet een relevant omslagpunt in zorgkosten ontstaat ten opzichte van andere extramurale aanbieders?	Hfst. 2, stap 3
Kunt u inzichtelijk maken welk deel van de kostenverschillen tussen VPT-aanbieders en andere extramurale aanbieders samenhangt met zorgverlening en welk deel met wonen en aanverwante componenten, en hoe deze verdeling is betrokken bij de vaststelling van de 85% grens?	Hfst. 2, stap 3
Kunt u inzichtelijk maken wat het verschil in vertrektarief is tussen een aanbieder met 84,9% VPT omzet en een aanbieder met 85,1% VPT omzet, en op welke verschillen in zorgkosten dit verschil is gebaseerd?	Hfst. 2, stap 3
Kunt u toelichten hoe is vastgesteld dat zorgaanbieders die op grond van de 85% VPT grens in hetzelfde cluster worden ingedeeld, een voldoende homogene zorgkostenstructuur hebben om één vertrektarief te rechtvaardigen?	Hfst. 2, stap 3
Kunt u toelichten waarom is gekozen voor een harde 85% grens zonder bandbreedte of aanvullende correctie voor wooncomponenten, terwijl niet is onderbouwd dat bij een aandeel van 85% VPT omzet een kwalitatief ander kostenprofiel ontstaat dan bij aanbieders die net onder of boven deze grens vallen?	Hfst. 2, stap 3
Kunt u inzichtelijk maken of en in welke omvang de NHC/NIC vergoeding overeenkomt met de feitelijke financieringslasten en baten van zorgaanbieders, en bevestigen of hierover voorafgaand aan de correctie een (kwantitatieve) analyse is uitgevoerd?	Hfst. 2, stap 2
Kunt u toelichten hoe groot het effect is op het richttariefpercentage per cluster ten aanzien van de aanname dat de NHC/NIC vergoeding de feitelijke vastgoedkosten dekt, gelet op het feit dat financieringslasten aan de kostenkant worden verwijderd en de referentieopbrengst exclusief NHC/NIC wordt bepaald?	Hfst. 2, stap 2
Kunt u inzichtelijk maken wat het effect is op het richttariefpercentage per cluster van de toepassing van de correctie voor de NHC/NIC	Hfst. 2, stap 2

component, bijvoorbeeld door een vergelijking te geven met een scenario waarin deze correctie achterwege blijft?	
Kunt u toelichten welk deel van de feitelijke financieringslasten na toepassing van de NHC/NIC correctie resteert en hoe deze resterende lasten doorwerken in de vaststelling van het richttariefpercentage?	Hfst. 2, stap 2
Kunt u toelichten op basis van welke gegevens is vastgesteld dat, ondanks de normatieve correctie voor NHC/NIC, de resterende tariefuitkomst nog reëel is voor zorgaanbieders met hogere feitelijke lasten?	Hfst. 2, stap 2
Kunt u inzichtelijk maken of en hoe is beoordeeld dat het hanteren van het 75e percentiel, na toepassing van de clusteringssystematiek en correcties zoals opgenomen in Bijlage 7, leidt tot tarieven die voor een representatief deel van de zorgaanbieders als reëel kunnen worden aangemerkt?	Hfst. 2, deel 3
Kunt u inzichtelijk maken welk effect de voorafgaande modelstappen (waaronder sectorindeling, vaste grenswaarden en correcties) hebben op de verdeling van kostenpercentages binnen een cluster, en daarmee op de hoogte van het 75e percentiel?	Hfst. 2, deel 3
Kunt u toelichten hoe is vastgesteld dat het 75e percentiel binnen de aldus gevormde clusters nog een representatief beeld geeft van de kostenstructuur van zorgaanbieders, gelet op de toegepaste selectie en correctiestappen?	Hfst. 2, deel 3
Kunt u toelichten op welke wijze is beoordeeld dat de uitkomst van het tariefmodel voldoet aan de maatstaf van reële tarieven, en niet uitsluitend dat de gehanteerde methode (het 75e percentiel) in eerdere rechtspraak is aanvaard?	Hfst. 2, deel 3
Waarom kiezen zorgkantoren ervoor om in de clustering onderscheid te maken tussen MPT en VPT terwijl in het Hoofdlijnenakkoord wordt toegewerkt naar één leveringsvorm?	Hfst. 2, stap 3

Specifieke vragen over het Wlz inkoopbeleid 2027 – 2029 van zorgkantoren

Zorgkantoor Zilveren Kruis

Vraag	Paragraaf
Maakt de gezamenlijke verhaallijn het voor (individuele) zorgaanbieders ook mogelijk om budgetten Zvw en Wlz in de eigen organisatie over de grenzen van Zvw (ten behoeve van Wlz-zorg) respectievelijk Wlz (ten behoeve van Zvw-zorg) in te zetten?	1.1
U stelt: Behandeling wordt expliciet afhankelijk gemaakt van de beschikbare contracteerruimte. De vraag of iemand in aanmerking komt voor behandeling is uiteindelijk aan de zorgaanbieder die goede zorg moet leveren en de professional die als goed hulpverlener moet handelen. Daartoe zijn zorgaanbieder en zorgprofessional wettelijk verplicht. Dit mag niet afhankelijk zijn van de beschikbare contracteerruimte. Is die ruimte onvoldoende om de zorgplicht van het zorgkantoor te realiseren dan zal het zorgkantoor het Rijk moeten	1.2

aanspreken op verruiming van de contracteerruimte. Wilt u deze zinsnede schrappen? Zo nee, waarom niet?	
U schrijft dat u verwacht dat zorgaanbieders actief aansluiten bij bestaande informele netwerken en steunstructuren in hun omgeving. Vanaf welk moment verwacht u dat? Wij kunnen ons voorstellen dat dat het geval is als er sprake is van één of meer cliënten in een informeel netwerk of steunstructuur, maar niet voordat er cliënten in beeld zijn. Ziet u dat ook zo? Zo nee, hoever gaat uw verwachting dat aanbieders actief op zoek gaan naar informele netwerken en steunstructuren in hun omgeving?	2.3
Met betrekking tot fysieke communities schrijft u dat welzijn en zorg aansluiten bij wat inwoners samen organiseren. Tegelijkertijd verwacht u van zorgaanbieders dat zij actief meedenken en het initiatief nemen. Wij interpreteren deze verwachting als volgt. Als een community een zorgaanbieder vraagt zich aan te sluiten of betrokken te zijn, dan wijst de zorgaanbieder dat niet af. Klopt onze interpretatie?	2.5
Een zorgzame gemeenschap, informele netwerk en steunstructuur, inwonersinitiatief en/of fysieke community kan een wijk of buurt betreffen of een particulier initiatief betreffen. Een zorgaanbieder in een stad of regio kan dan betrokken zijn bij misschien wel 20 tot 100 initiatieven. Hoe ziet u de rol van de zorgaanbieder in zo'n situatie voor zich?	2.5
U schrijft dat u het belangrijk vindt dat ouderen zoveel mogelijk zelf richting kunnen blijven geven aan hun leden en dat u daarom inzet op het versterken van hun zelfredzaamheid. Hoe gaat Zilveren Kruis en/of Zilveren Kruis zorgkantoor inzetten op het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen? Moeten we daarbij denken aan (regionale) campagnes of gaat u (technologische) innovaties verstrekken? Graag een toelichting.	3.1
U schrijft bij reablement dat we er samen voor zorgen dat ouderen leven zoals zij willen en dat we beginnen bij wat iemand zelf wil en kan. 'We' impliceert Zilveren Kruis en/of Zilveren Kruis zorgkantoor en de zorgaanbieders. Over de rol van zorgaanbieders vinden we voldoende aanwijzingen in het inkoopbeleid. Welke rol speelt Zilveren Kruis bij het samen zorgen dat ouderen leven zoals zij willen?	3.2
In de paragraaf 'Voor zorg thuis met een MPT stimuleren we de inzet van thuiszorgtechnologie' schrijft u dat thuiszorgtechnologie ter vervanging is van fysieke zorg of leidt tot uitstel van fysieke zorg. Thuiszorgtechnologie die dus geen aantoonbare relatie heeft met fysieke zorg kan dus niet worden ingezet. Klopt dat? Zo nee, graag een toelichting.	3.4
In de paragraaf 'Voor zorg thuis geldt MPT voorliggend op VPT' stelt u eerst dat zorgaanbieders bij bestaande klanten die nu een VPT krijgen, in goed overleg met de klant, kunnen overstappen naar een MPT. Daarna schrijft u dat u daadwerkelijk een andere leveringsmix verwacht van zorgaanbieders die een VPT declareren (waarbij overleg met de klant niet wordt genoemd). Hoe moeten wij de combinatie van deze twee zinnen interpreteren? Wat is het echte beleid dat u voorstaat met betrekking tot de huidige klanten die een VPT ontvangen?	4.2
In het HLO is afgesproken dat het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd' uitsluitend geldt voor nieuwe cliënten. In het inkoopbeleid is opgenomen dat ook bestaande cliënten die momenteel VPT ontvangen kunnen worden overgezet naar een MPT. Zorgkantoor Zilveren Kruis kijkt hiermee af de landelijk vastgestelde kaders. Wij verzoeken u	4.2

aan te sluiten bij deze afspraken. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	
Met betrekking tot het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd', veronderstellen wij dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de WLZ? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	4.2
Kunt u bevestigen of zorgaanbieders vanaf 2027 de principes mogen toepassen die Zorgkantoor DSW hanteert in de 'Pilot verminder gebruik AAT en rekenmodule'?	4.2
Bent u het er mee eens als wij als zorgaanbieder vanaf 2027 de principes gaan toepassen zoals Zorgkantoor DSW deze hanteert in de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dat betekent dat wij voor cliënten met MPT alleen een AAT in dienen als er een nieuwe aanbieder bij de zorg wordt betrokken, of als de leveringsvorm wijzigt, of als de zorg niet verantwoord geleverd kan worden. Zo nee, waarom niet?	4.2
Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	4.2
De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	4.2
U schrijft in paragraaf 5.2 dat het volumeplafond in principe geldt voor de volledige beleidsperiode. Kunt u toelichten wat u bedoelt met 'in principe'?	5.2
In paragraaf 5.2 staat dat u verwacht dat wij het hele jaar door voldoende zorg met verblijf beschikbaar houden en dat wij contact opnemen als we in een maand meer declareren dan past binnen het volumeplafond. Dat snappen wij niet. Het is niet vreemd als wij op jaarbasis binnen het volumeplafond (dat op jaarbasis berekend is) 6 keer boven het maandgemiddelde declareren en 6 keer daaronder. Verwacht u dan dat wij daar 6 keer contact over zoeken?	5.2
In paragraaf 5.3 stelt u als voorwaarde voor nieuw aanbod van logeerszorg dat de plekken voor logeerszorg speciaal gereserveerd blijven voor logeerszorg. Daarmee geeft u aan dat deze plekken een beschikbaarheidsfunctie hebben en dus als volume op jaarbasis worden vergoed (en dus niet worden aangepast bij herschikking of nacalculatie)? Klopt dat? Zo nee, dan graag een toelichting hoe we deze voorwaarde moeten interpreteren?	5.3
In u beleid beschrijft u een aantal groepen voor wie zorg met verblijf beschikbaar moet blijven. Het nog op te stellen afwegingskader/de opnametoets in het kader van het HLO ziet toe op de vraag welke cliënten zijn aangewezen op zorg met verblijf. Kunt u toelichten waarom Zilveren Kruis hier in het beleid op vooruitloopt en reeds eigen uitgangspunten en cliëntgroepen hanteert?	6.1
Met betrekking tot de keuze voor een beperkt aantal aanbieders voor afspraken over essentiële voorzieningen geeft u aan hiervoor een vaste beoordelingsmethode te gebruiken met duidelijke onderdelen. Deze	6.7

beoordelmethode is niet opgenomen in het inkoopbeleid. Wilt u deze beoordelmethode delen met het oog op transparantie? Zo nee, waarom niet?	
U geeft aan dat met geselecteerde zorgaanbieders afspraken worden gemaakt over het borgen van essentiële voorzieningen, waarvoor middelen uit het regiobudget HLO beschikbaar worden gesteld. Kunt u toelichten waarom de middelen uit het regiobudget HLO niet toegankelijk zijn voor alle aanbieders?	6.7
U stelt dat middelen voor DOS-preventieve maatregelen voorrang hebben op middelen uit het regiobudget HLO. Kunt u nader toelichten wat in dit verband wordt verstaan onder 'voorrang'?	6.8
U geeft aan dat het inkoopbeleid DOS Preventieve Maatregelen naar verwachting medio juni 2026 wordt gepubliceerd. Eerder is gecommuniceerd dat dit beleid al in mei beschikbaar zou komen. Kunt u toelichten wat de oorzaak is van deze vertraging, mede gelet op het feit dat dit beleid ook nog betrekking heeft op 2026?	6.8
In het inkoopbeleid staat dat u het belangrijkste deel van de contracteerruimte gebruikt voor de vergoeding van de tariefpercentages voor zorg en voor de NHC/NIC en 0,2% reserveert voor onvoorziene omstandigheden. Betekent dit dat 99.8% van de contracteerruimte voor vergoeding van de tariefpercentages voor zorg en de NHC/NIC beschikbaar is en uitgegeven wordt via zorgaanbieders?	7.1
"Aanbieders in een groep leveren dezelfde zorg en hebben een vergelijkbare bedrijfsvoering op basis van objectieve kenmerken." Kunt u toelichten wat deze 'objectieve kenmerken' zijn?	7.2
In het document wordt gesteld dat het verfijnde model voor tariefdifferentiatie wordt ingevoerd "om meer recht te doen aan verschillen tussen zorgaanbieders zoals gevraagd door de branches". Wij herkennen ons niet in deze weergave. Voor zover ons bekend hebben de brancheorganisaties niet verzocht om de invoering van dit specifieke model of om verdere tariefdifferentiatie op de wijze zoals nu wordt voorgesteld. Wij verzoeken u daarom deze passage te verwijderen dan wel aan te passen, tenzij u kunt onderbouwen welke brancheorganisaties dit verzoek hebben gedaan. Zonder deze onderbouwing wekt de huidige formulering ten onrechte de indruk dat er vanuit de branches draagvlak bestaat voor deze wijziging. Bent u bereid tot deze wijziging? Zo nee, waarom niet?	7.2
U geeft in paragraaf 7.3 aan dat Zilveren Kruis voor de bestaande zorgaanbieders het landelijke vertrektariefpercentage afsprekt voor zorg, waarbij het tariefpercentage van het cluster waarin de zorgaanbieder valt geldt. Hier lopen twee begrippen door elkaar. Onzes inziens neemt Zilveren Kruis de landelijke vertrektariefpercentages over om met de aanbieders identieke tariefpercentages af te spreken. Klopt dat? Zo nee, graag een toelichting.	7.3
In het beleid wordt enerzijds gesteld dat met alle bestaande zorgaanbieders het landelijke vertrektariefpercentage wordt afgesproken, waarbij het tariefpercentage van het cluster waarin de zorgaanbieder valt leidend is. Anderzijds wordt aangegeven dat met een deel van de zorgaanbieders een lager tariefpercentage wordt afgesproken dat 2% onder het vertrektariefpercentage ligt.	7.3 en 7.4

Onzes inziens spreken deze passages elkaar tegen. Kunt u toelichten hoe deze twee uitgangspunten zich tot elkaar verhouden?	
In paragraaf 7.4 geeft u aan dat u met zorgaanbieders in gesprek kan gaan om maatwerkafspraken te maken over het tariefpercentage met het oog op doelmatigheid. Kunt u een voorbeeld geven van hoe zo'n maatwerkafpraak eruit zou kunnen zien? Blijft het tariefpercentage dan ongewijzigd en hebben de afspraken betrekking op het realiseren van doelmatigheid?	7.4
Bij de hardheidsclausule wordt aangegeven dat in het kader van de financiële positie ook de financiële reserves van de zorgaanbieder worden betrokken. Veel financiële reserves worden gecreëerd met het oog op investeringen op lange(re) termijn. Wij hebben er bewaar tegen dat die worden betrokken bij de beoordeling van de financiële positie van de zorgaanbieder. Kunt u bevestigen dat doelreserves/voorzieningen geen deel uitmaken van financiële positie in het kader van de beoordeling van de hardheidsclausule?	7.5
De vergoeding van sectorvreemde zorg wijzigt. Dat is helder verwoord. Niet helder is de zin dat als een zorgaanbieder sectorvreemde zorg levert, deze met de zorginkoper af moet spreken of de aanbieder deze zorg kan leveren en declareren. Moet ook een zorgaanbieder die al jaren sectorvreemde zorg levert en nu door uw systeemwijziging te maken krijgt met een andere vergoeding het gesprek aan met de zorginkoper of kunt u bevestigen dat het in dei gevallen niet nodig is? Graag uw reactie.	7.7
U geeft aan dat een goede verantwoording van geleverde meerzorg van belang is en dat hiervoor onder meer evaluaties en materiële controles worden ingezet, waarbij van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij de inzet van meerzorgmiddelen inhoudelijk en financieel kunnen onderbouwen. In de praktijk ervaren zorgaanbieders de administratieve lasten rondom de verantwoording van meerzorg al jaren als zeer hoog. Kunt u toelichten op welke wijze het zorgkantoor voornemens is deze administratieve lasten te verlagen en te komen tot een meer proportionele en doelmatige verantwoordingssystematiek?	8.1
Zorgkantoor Zilveren Kruis stelt als voorwaarden voor MGZ dat er een structurele regionale governance beschikbaar is. Deze voorwaarde vloeit niet voort uit het Convenant. Kan het zorgkantoor toelichten waarom wordt afgeweken van het convenant?	8.2
In het inkoopbeleid is opgenomen dat wanneer het aanbieders niet lukt om afspraken te maken, dit gemeld dient te worden bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan vervolgens landelijk escaleren. In het Convenant is echter afgesproken dat het tot de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor behoort om de regio, indien nodig, bijeen te roepen gezamenlijk toe te werken naar een oplossing. Waarom kiest het zorgkantoor ervoor om af te wijken van de afspraken in het Convenant?	8.2
Wij merken op dat in deze passage ontbreekt dat zorgkantoren toezeggen bij de MGZ-afspraken passende inkoopafspraken te maken. Kunt u dit alsnog toevoegen? Zo nee, waarom niet?	8.2

In paragraaf 8.3 schrijft u dat u VPT zorg alleen nog afsprekt zonder behandeling. Als een VPT klant behandeling nodig heeft dan kan dat via extramurale behandeling. Betekent dit dat voor alle VPT klanten die nu een VPT met behandeling hebben deze behandelen per 1 januari a.s. omgezet moet worden in extramurale behandeling? Waarom beperkt u deze afspraak niet tot nieuwe VPT klanten vanaf 2027?	8.3
Voor zorg met verblijf maakt u afspraken over plekken met behandeling. U schrijft dat het uitgangspunt is dat het aantal dagen met behandeling gelijk blijft. De afspraak voor 2027 baseert u op het totaal aantal gedeclareerde en vergoede dagen in 2025. Waarom baseert u de afspraak voor 2027 niet op de definitieve herschikkingsafpraak 2026?	8.3
Het uitgangspunt in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis is dat het aantal dagen met behandeling gelijk blijft en dat een vast aantal plekken met behandeling wordt afgesproken voor alle VV-verblijfprestaties. De zorgwaarde van de cliëntpopulatie neemt echter toe en aanbieders geven aan dat historische ratio's daardoor niet langer passend zijn. In het HLO is daarnaast een beweging richting 100% inclusief behandeling opgenomen. Kunt u toelichten hoe Zilveren Kruis zich tot deze ontwikkeling verhoudt en waarom wordt gekozen voor dit uitgangspunt?	8.3
U stelt: Het uitgangspunt is dat het aantal dagen met behandeling gelijk blijft. Kunt u bevestigen dat zorgaanbieders een aantal dagen met behandeling af kunnen spreken met het zorgkantoor dat passend is bij de zorgvraag van de cliëntenpopulatie van de aanbieder? Zo nee, waarom niet?	8.3
Kan het zorgkantoor verduidelijken of de genoemde toepassingen bedoeld zijn als voorbeelden van kansrijke werkwijzen, of als concrete verwachting richting alle Wlz-aanbieders? En als het laatste het geval is: op basis van welke onderbouwing, voor welke doelgroepen en met welke randvoorwaarden en bekostiging?	8.5
Hoe beoordeelt het zorgkantoor of de innovatie bewezen effectief is? Wordt daarbij ook rekening gehouden met medewerkers- en clienttevredenheid, administratieve lastenverlichting, etc.?	8.5
Wij onderschrijven dat de genoemde innovaties veelbelovend kunnen zijn, mits zij zorgvuldig en contextafhankelijk worden geïmplementeerd. Wij zijn het echter niet eens met de stelling dat deze innovaties reeds bewezen effectief zijn binnen de intramurale setting. Voor sommige innovaties, waaronder beeldzorg, wordt bovendien nog gewerkt aan een gezamenlijk standpunt. Daarmee achten wij het te stellig om deze innovaties te presenteren als overall bewezen effectief, overall toepasbaar of zonder meer verplichtend. Wij verzoeken het zorgkantoor deze nuance expliciet in de passage te verwerken. Is het zorgkantoor bereid de passage op dit punt aan te passen? Zo nee, waarom niet?	8.5
In het inkoopbeleid wordt gesteld dat de zorgaanbieder ambassadeur is van het innovatietraject. Kunt u verduidelijken of Zilveren Kruis hierin wel cofinanciering beschikbaar stelt voor de innovatie? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten waarom ervoor gekozen is geen financiële bijdrage te	8.5

leveren aan deze trajecten? Andere zorgkantoren hanteren voor innovatieprojecten immers wel vormen van cofinanciering.	
Sinds 1 juli 2024 is het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan van kracht voor de VV. Het Generiek Kompas heeft kwaliteit van bestaan als uitgangspunt. Is er een reden waarom er in uw inkoopbeleid is afgeweken van het taalgebruik van het Generiek Kompas (kwaliteitskader in plaats van het Generiek Kompas en kwaliteit van leven in plaats van kwaliteit van bestaan)?	8.6
U geeft aan in gesprek te gaan met zorgaanbieders met een hoog positief resultaat. Kunt u toelichten wat u verstaat onder een 'hoog positief resultaat'? En kunt u vervolgens toelichten op welke analyses de keuze voor deze grens is gebaseerd en welke betekenis aan deze grens wordt toegekend bij de beoordeling of een gesprek over het tarief plaatsvindt?	8.8
Kunt u toelichten hoe wordt omgegaan met zorgaanbieders waarvan het rendement zich rond de door het zorgkantoor gehanteerde grens bevindt en hoe een consistente toepassing wordt geborgd?	8.8
Kunt u toelichten welke mogelijke uitkomsten het genoemde gesprek bij 'een hoog positief resultaat' kan hebben en in hoeverre het zorgkantoor daarbij beleidsruimte heeft om het tarief aan te passen?	8.8
Kunt u toelichten welke afwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de keuze om bij 'een hoog positief resultaat' een gesprek over het tarief te voeren, mede in het licht van investeringen en continuïteit van zorg?	8.8
Kunt u bevestigen dat het rendement van een hoog positief rendement wordt berekend als het nettoresultaat gedeeld door de som der bedrijfsopbrengsten, en toelichten waarom dit totale ondernemingsrendement wordt gehanteerd als criterium bij de beoordeling of een gesprek over het tarief wordt gevoerd?	8.8
Kunt u toelichten over welke periode het rendement wordt vastgesteld en op basis van welke financiële gegevens?	8.8
Het wetsvoorstel Wet bevordering integriteit zorgaanbieders stelt regels ten aanzien van de marktconformiteit van transacties en winstuitkeringen. Om te voorkomen dat zorgaanbieders moeten werken met twee verschillende normen (een wettelijk, een contractueel) voor hetzelfde vraagstuk willen wij het zorgkantoor verzoeken om pas op de plaats te maken en de wetgeving terzake af te wachten. Bent u hiertoe bereid? Is dit rechtmatig? Is dit spannend voor onze leden?	8.11
Op grond van welke criteria komt een aanbieder in aanmerking voor een overeenkomst van drie jaar?	10.18
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	10.24
Dit nieuwe Inkoopbeleid voor 2027-2029 is een nieuw inkoopbeleid voor de komende drie jaar. Het is voor aanbieders onmogelijk in één vragenprocedure alle mogelijke consequenties te overzien. De antwoorden die op de vragen gegeven worden en worden gepubliceerd op 1 juli a.s. kunnen aanleiding zijn voor aanvullende vragen. Omdat het gaat voor een inkoopbeleid voor 3 jaar verzoeken wij u om na het verschijnen van de Nota van Inlichtingen nogmaals de gelegenheid te geven voor het stellen van vragen. Gaat u ons verzoek voor een tweede ronde van de vragenprocedure overnemen? Zo nee, waarom niet?	10.4

In 10.7 geeft u aan dat een aanbieder in moet schrijven "bij die zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de regio waarbinnen u zorg levert of wilt leveren". Dit is niet duidelijk. In dit document lijkt het woord regio steeds overeen te komen met zorgkantoorregio's en in zorgkantoorregio's is maar één zorgkantoor verantwoordelijk. Het kan zijn dat u in dit geval met regio het werkgebied van zorgaanbieders bedoelt, die betrekking kan hebben op meer zorgkantoorregio's. Kunt u nader toelichten wat hier wordt bedoeld en/of de betreffende zin aanpassen?	10.7
In paragraaf 10.8 schrijft u: Als de inschrijving van de zorgaanbieder wordt afgewezen n.a.v. de inschrijving uiterlijk 31 juli 2026 17.00 uur, heeft de zorgaanbieder geen mogelijkheid meer om opnieuw (tussentijds) in te schrijven voor het betreffende jaar (2027). Hij kan zich dan pas in de zomer van 2027 weer inschrijven om voor een overeenkomst voor 2028 in aanmerking te komen. Betreft dit alleen nieuwe aanbieders of ook bestaande aanbieders die al één of veel meer jaren een contract met Zilveren Kruis hebben?	10.8
U schrijft in paragraaf 10.11 dat wij met de inschrijving en ondertekening van de bestuursverklaring instemmen met het geschetste inkoopperspectief voor de komende 3 jaar. Leidt de 'instemming' met het perspectief tot beperkingen in de mogelijkheden van het stellen van vragen over het inkoopbeleid in de komende jaren? Wij refereren daarbij aan de afgelopen jaren, waarbij vragen stellen beperkt werd tot gewijzigde onderdelen van het inkoopbeleid. Als dat zo is, dan hebben we daar bezwaar tegen, want ook gewijzigde omstandigheden kunnen leiden tot een ander inzicht op het inkoopbeleid en leiden tot nieuwe vragen over het inkoopbeleid dat op zichzelf ongewijzigd wordt voortgezet.	10.11
In paragraaf 10.22 wordt ingegaan op de vervalttermijn voor kortgeding tegen de tarieven en voorlopige terugkoppeling. Ten aanzien van de tarieven wordt alleen ingegaan op de definitieve vertrektarieven, maar niet op de tarieven van Zilveren Kruis, die qua hoogte hetzelfde zijn, maar geen vertrektarieven zijn. Wij nemen aan dat de kortgedingprocedure ook de tarieven van Zilveren Kruis omvat. Klopt dat? Zo nee, wanneer en/of hoe kan daar dan een procedure tegen worden gestart?	10.22
In paragraaf 11.4 overerschikking schrijft u: 'Zijn de middelen per sector niet toereikend? Dan passen we een onzekerheidspercentage toe op de geëxtrapoleerde productierealisatie van dat jaar.' Dit begrijpen wij niet. Gaat het om sectoren of om de clusters binnen de sectoren? Wat bedoelt u met 'onzekerheidspercentage' en hoe wordt dat dan toegepast. Kunt u met een voorbeeld aangeven wat in deze zinnen overerschikking u bedoelt?	11.4
Bij de definitieveerschikking staat: "Voor de definitieve productieafsprake gebruiken we de goedgekeurde declaratiegegevens uit de AW319 van het betreffende kalenderjaar. We gebruiken daarvoor uw goedgekeurde declaraties tot en met juni op peildatum 1 augustus van elk jaar als de basis voor deerschikking.." Ook geeft u aan: "In deerschikking extrapoleren wij op basis van goedgekeurde declaraties." Wij nemen aan dat wij voldoende ruimte houden om in de periode na heterschikkingsmoment het volumeplafond nog te realiseren als wij op het moment van deerschikking naar verhouding onder het volumeplafond zitten. Er zijn dan immers nog een aantal maanden te gaan en bij de nacalculatie kan de productie alsnog worden gecorrigeerd indien nodig. Is dit conform hoe u voornemens bent hiermee om te gaan? Zo niet, hoe is uw werkwijze dan precies?	11.4
U stelt: als er meer dagen verblijf met behandeling worden gedeclareerd dan overeengekomen, worden deze <i>bij voorbaat</i> uitgesloten van de nacalculatie. Uiteindelijk is de zorgbehoefte van cliënten leidend voor het vervullen van de zorgplicht van zorgkantoren. Dat kan resulteren in meer dagen verblijf met behandeling dan gecontracteerd. Onder die omstandigheid is	11.5

het niet redelijk om een overschrijding bij voorbaat af te straffen door een uitsluiting van de nacalculatie. Bent u bereid deze voorwaarde te schrappen?	
---	--

Zorgkantoor CZ

Vraag	Paragraaf
U stelt dat de kompassen en het kader, naast de professionele standaarden en richtlijnen, de basis voor gesprekken met zorgaanbieders over kwalitatief goede zorg vormen. Kunt u bevestigen dat het zorgkantoor geen aanvullende eisen stelt bovenop deze wet- en regelgeving? Zo nee, waarom niet?	1.5
U schrijft: "Wij hanteren een duidelijke volgordelijkheid: het Modulair Pakket Thuis (MPT) is voorliggend op het Volledig Pakket Thuis (VPT). Kunt u toelichten waarom binnen deze systematiek onderscheid wordt gemaakt tussen geclusterd en ongeclusterd VPT en op welke gronden dit onderscheid wordt gerechtvaardigd?	1.6
U schrijft: "Wij hanteren een duidelijke volgordelijkheid: het Modulair Pakket Thuis (MPT) is voorliggend op het Volledig Pakket Thuis (VPT). Beide extramurale leveringsvormen gaan voor op intramuraal verblijf. Deze volgordelijkheid is gebaseerd op het uitgangspunt dat MPT en VPT passende alternatieven kunnen bieden voor verblijf."	1.6
Wij veronderstellen dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de WLZ? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	
In het inkoopbeleid wordt beschreven dat van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij voorafgaand aan intramurale opname op de genoemde punten een zorgvuldige check uitvoeren. Dit geldt ook voor bestaande intramurale cliënten waarbij de mogelijkheid is om uit te stromen naar een vorm van zorg thuis.	1.6
Wij veronderstellen dat het zorgkantoor hiermee vooruitloopt op het nog nader uit te werken en vast te stellen afwegingskader. Welke vorm van controle voert het zorgkantoor uit op de naleving van deze verwachting?	
In het inkoopbeleid wordt beschreven dat van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij voorafgaand aan intramurale opname op de genoemde punten een zorgvuldige check uitvoeren. Dit geldt ook voor bestaande intramurale cliënten waarbij de mogelijkheid is om uit te stromen naar een vorm van zorg thuis.	1.6
In hoeverre acht het zorgkantoor het in de praktijk uitvoerbaar en verantwoord om bestaande intramurale cliënten uit te laten stromen naar een vorm van zorg thuis? De keuzevrijheid van de cliënt is hierin leidend en bovendien heeft de zorgvuldige afweging voor intramurale opname al plaatsgevonden.	
Wij hanteren een duidelijke volgordelijkheid: het Modulair Pakket Thuis (MPT) is voorliggend op het Volledig Pakket Thuis (VPT).	1.6

In het inkoopbeleid spreekt Zorgkantoor CZ van een duidelijke volgordelijkheid: het Modulair Pakket Thuis (MPT) is voorliggend op het Volledig Pakket Thuis (VPT). Wij missen hier de termen 'in principe' en 'ongeclusterd'. Wij nemen aan dat Zorgkantoor CZ aansluit bij het landelijke beleid 'MPT in principe voorliggend op het VPT ongeclusterd' en hierbij ook het landelijke toetsingskader toepast. Kan het zorgkantoor dit bevestigen?	
Kan het zorgkantoor verduidelijken of de genoemde toepassingen bedoeld zijn als voorbeelden van kansrijke werkwijzen, of als concrete verwachting richting alle Wlz-aanbieders? En als het laatste het geval is: op basis van welke onderbouwing, voor welke doelgroepen en met welke randvoorwaarden en bekostiging?	1.8.1
Hoe beoordeelt het zorgkantoor of de innovatie bewezen effectief is? Wordt daarbij ook rekening gehouden met medewerkers- en clienttevredenheid, administratieve lastenverlichting, etc.?	1.8.1
Wij onderschrijven dat de genoemde innovaties veelbelovend kunnen zijn, mits zij zorgvuldig en contextafhankelijk worden geïmplementeerd. Wij zijn het echter niet eens met de stelling dat deze innovaties reeds bewezen effectief zijn binnen de intramurale setting. Voor sommige innovaties, waaronder beeldzorg, wordt bovendien nog gewerkt aan een gezamenlijk standpunt. Daarmee achten wij het te stellig om deze innovaties te presenteren als overall bewezen effectief, overall toepasbaar of zonder meer verplichtend. Wij verzoeken het zorgkantoor deze nuance expliciet in de passage te verwerken. Is het zorgkantoor bereid de passage op dit punt aan te passen? Zo nee, waarom niet?	1.8.1
In het inkoopbeleid wordt gesteld dat de zorgaanbieder ambassadeur is van het innovatietraject. Kunt u verduidelijken of Zorgkantoor CZ hierin wel cofinanciering beschikbaar stelt voor de innovatie? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten waarom ervoor gekozen is geen financiële bijdrage te leveren aan deze trajecten? Andere zorgkantoren hanteren voor innovatieprojecten immers wel vormen van cofinanciering.	1.8.1
U geeft aan dat het zorgkantoor regie neemt op een toegankelijk, betaalbaar en toekomstbestendig regionaal zorgaanbod, op basis van data, regiobeelden en signalen uit de praktijk, met bijzondere aandacht voor cliënten met complexe zorgvragen. Biedt het zorgkantoor binnen deze regierol ook expliciet ruimte om de invulling hiervan gezamenlijk met zorgaanbieders in de regio te bespreken, en op welke wijze wordt deze samenwerking vormgegeven?	1.9.1
U beschrijft dat er een regionale concretisering plaatsvindt van het landelijke toetsingskader omtrent MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd. In het HLO is afgesproken te werken met één landelijk toetsingskader, juist om te voorkomen dat er per zorgkantoor verschillende interpretaties of uitwerkingen ontstaan. Kunt u toelichten hoe de genoemde "regionale concretisering" zich verhoudt tot dit uitgangspunt, en op welke wijze wordt geborgd dat zorgaanbieders niet	2.4.3.1

met verschillende regionale interpretaties van hetzelfde landelijke kader worden geconfronteerd?	
Kunt u bevestigen of zorgaanbieders vanaf 2027 de principes mogen toepassen die Zorgkantoor DSW hanteert in de 'Pilot verminder gebruik AAT en rekenmodule'? Bent u het er mee eens als wij als zorgaanbieder vanaf 2027 de principes gaan toepassen zoals Zorgkantoor DSW deze hanteert in de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dat betekent dat wij voor cliënten met MPT alleen een AAT in dienen als er een nieuwe aanbieder bij de zorg wordt betrokken, of als de leveringsvorm wijzigt, of als de zorg niet verantwoord geleverd kan worden. Zo nee, waarom niet?	2.4.3.1
Bent u bereid om de regels in het Voorschrift Zorgtoewijzing aan te passen conform de principes in voornoemde pilot van Zorgkantoor DSW? Zo nee, waarom niet?	2.4.3.1
In het VPT hebben wij de mogelijkheid om medewerkers in te zetten die zich bezighouden met o.a.: • met ondersteuning van het netwerk van de cliënt, waaronder mantelzorgers en andere vormen van informele zorg; • het ondersteunen van de cliënt met het onderhouden en instandhouden van dat netwerk; • zorgcoördinatie en – regie; • welzijn en welbevinden. Dit is essentieel voor onze cliënten om langer thuis te kunnen blijven wonen. Kunt u aangeven hoe wij deze en soortgelijke activiteiten kunnen aanbieden binnen het MPT? Mogen wij voor de registratie en declaratie hiervan de prestatie begeleiding (NZA-prestatiecode H300) hanteren? Zo nee, waarom niet en welke prestatie kunnen wij hiervoor dan wel gebruiken?	2.4.3.1
Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	2.4.3.1
U schrijft: "Uitbreiding van wooninitiatieven met uitsluitend Wlz-cliënten is niet vanzelfsprekend." Bedoelt u daarmee nieuwe zorgaanbieders, of ook bestaande aanbieders? En geldt dit ook voor vervanging van intramurale capaciteit door extramurale initiatieven? Zo ja, waarom?	2.4.2
U schrijft over een "regiotafel nieuwe stijl". Kunt u toelichten wat hieronder wordt verstaan? Betreft dit een nieuwe, aanvullende overlegstructuur naast de bestaande regionale overleggen, of wordt hiermee een bestaande overlegvorm aangepast of doorontwikkeld? Indien sprake is van een nieuwe overlegstructuur, hoe voorkomt u dat dit leidt tot extra overleg- en administratieve lasten voor zorgaanbieders?	3.1
In het document wordt gesteld dat het verfijnde model voor tariefdifferentiatie wordt ingevoerd "om meer recht te doen aan verschillen tussen zorgaanbieders zoals gevraagd door de branches". Wij herkennen ons niet in deze weergave. Voor zover ons bekend hebben de	4.2.1

brancheorganisaties niet verzocht om de invoering van dit specifieke model of om verdere tariefdifferentiatie op de wijze zoals nu wordt voorgesteld. Wij verzoeken u daarom deze passage te verwijderen dan wel aan te passen, tenzij u kunt onderbouwen welke brancheorganisaties dit verzoek hebben gedaan. Zonder deze onderbouwing wekt de huidige formulering ten onrechte de indruk dat er vanuit de branches draagvlak bestaat voor deze wijziging. Bent u bereid tot deze wijziging? Zo nee, waarom niet?	
U stelt: "Aanbieders in een groep leveren dezelfde zorg en hebben een vergelijkbare bedrijfsvoering op basis van objectieve kenmerken". Kan het zorgkantoor toelichten wat deze objectieve criteria zijn?	4.2.1
De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	4.3
Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan de gehanteerde afslag van 2% voor nieuwe zorgaanbieders?	4.3.1
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	4.3.1
U geeft aan in gesprek te gaan met zorgaanbieders die een hoog positief resultaat behalen over de mogelijkheden om een lager tariefpercentage af te spreken. Kunt u verduidelijken wat u onder 'een hoog positief resultaat' verstaat? En kunt u vervolgens toelichten op welke analyses de keuze voor deze grens is gebaseerd en welke betekenis aan deze grens wordt toegekend bij de beoordeling of een gesprek over het tarief plaatsvindt?	4.3.2
U geeft aan in gesprek te gaan met zorgaanbieders die een hoog positief resultaat behalen over de mogelijkheden om een lager tariefpercentage af te spreken. Kunt u toelichten hoe wordt omgegaan met zorgaanbieders waarvan het rendement zich rond de door het zorgkantoor gehanteerde grens bevindt en hoe een consistente toepassing wordt geborgd?	4.3.2
U geeft aan in gesprek te gaan met zorgaanbieders die een hoog positief resultaat behalen over de mogelijkheden om een lager tariefpercentage af te spreken. Kunt u toelichten welke mogelijke uitkomsten het genoemde gesprek bij 'een hoog positief resultaat' kan hebben en in hoeverre het zorgkantoor daarbij beleidsruimte heeft om het tarief aan te passen?	4.3.2
U geeft aan in gesprek te gaan met zorgaanbieders die een hoog positief resultaat behalen over de mogelijkheden om een lager tariefpercentage af te spreken.	4.3.2

Kunt u toelichten welke afwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de keuze om bij 'een hoog positief resultaat' een gesprek over het tarief te voeren, mede in het licht van investeringen en continuïteit van zorg?	
Kunt u bevestigen dat het rendement wordt berekend als het nettoresultaat gedeeld door de som der bedrijfsopbrengsten, en toelichten waarom dit totale ondernemingsrendement wordt gehanteerd als criterium bij de beoordeling of een gesprek over het tarief wordt gevoerd?	4.3.2
Kunt u toelichten over welke periode het rendement wordt vastgesteld en op basis van welke financiële gegevens?	4.3.2
U noemt dat u in het verleden gebruikmaakte van cliëntvolgende bekostiging. Waarom laat u dat nu los en in hoeverre past dat bij het recht van de Wlz-geïndiceerde cliënt?	4.4
Mogen zorgaanbieders binnen dit nieuwe beleid van volumesturing zorg weigeren indien de overeengekomen volumeafspraken op enig moment niet langer toereikend zijn? Indien dit niet is toegestaan, kunt u toelichten bij welke partij het financiële risico ligt van zorg die wordt geleverd boven de overeengekomen volumes?	4.4
Kunt u toelichten welke doelstellingen u met dit beleid van volumesturing beoogt te bereiken?	4.4
In paragraaf 4.6 zien wij geen verwijzing naar de toepassing van de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking ten behoeve van de regionale transformatie. Ook in de overige onderdelen van het inkoopdocument komt dit niet naar voren. Kunt u toelichten wat uw visie en beleid zijn ten aanzien van de wet DOS en om welke reden dit geen expliciete plaats heeft gekregen in het inkoopbeleid?	4.6
Als voorwaarde voor het in aanmerking komen van een project noemt u dat "sprake is van regionaal draagvlak en samenwerking met betrokkenheid van meerdere partijen". Kunt u verduidelijken hoe deze voorwaarde moet worden geïnterpreteerd? Is het vereist dat de betrokken partijen bestaan uit één of meerdere Wlz-zorgaanbieders, of kan ook sprake zijn van een samenwerkingsverband tussen één Wlz-zorgaanbieder en één of meer partijen uit andere domeinen, zoals bijvoorbeeld een gemeente?	4.6.2
U schrijft dat u vanaf 2027 werkt met een tweezijdige indiening van de initiële productieafpraak van €1 bij de NZa. Waarom kiest het zorgkantoor hiervoor?	4.8
In het schema op pagina 39 wordt bij activiteit 16 verwezen naar het addendum "Free Proposal". Wij zien deze term verder niet terug in het inkoopdocument. Kunt u bevestigen of deze verwijzing per abuis is overgenomen uit een eerdere versie van het inkoopbeleid? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten wat onder een "Free Proposal" wordt verstaan, welke	5.6

voorwaarden hiervoor gelden en op welke wijze zorgaanbieders hiervoor in aanmerking kunnen komen?	
U geeft aan dat de maximaal te vergoeden verhouding tussen verblijf inclusief en exclusief behandeling wordt gebaseerd op de productieafspraken van jaar t-1 en, indien nodig, gedurende het jaar wordt bijgesteld. Kunt u toelichten welke omstandigheden of criteria aanleiding kunnen zijn voor een dergelijke bijstelling gedurende het jaar? Daarnaast vernemen wij graag of zorgaanbieders zelf een verzoek tot aanpassing van deze verhouding kunnen indienen wanneer de feitelijke zorgvraag of cliëntenmix daar aanleiding toe geeft.	2.4.4
Met ingang van 1 januari 2026 is de wet Domein overstijgende samenwerking (DOS) in werking getreden. Wanneer maakt het zorgkantoor het DOS-beleid bekend met de voorwaarden voor nieuwe projecten en de continuering van de bestaande projecten?	Generiek

Zorgkantoor Menzis

Vraag	Paragraaf
Er wordt gesproken over het slimmer omgaan met de inzet van personeel, bijvoorbeeld door nieuwe rollen, een andere taakverdeling en intensievere samenwerking tussen zorgprofessionals en het netwerk van de cliënt. Kan het zorgkantoor aangeven waaraan zij denkt als het gaat om nieuwe rollen, andere taakverdeling en intensievere samenwerking?	1.1
Wat verstaat Zorgkantoor Menzis onder passende huisvesting in woonzorggebouwen en aan welke voorwaarden dient dit te voldoen? Sluit dit aan bij de huidige wijze waarop woonzorggebouwen zijn gerealiseerd?	1.1
Er wordt gesproken over een toekomstbestendig en passend aanbod van huisvesting binnen een dekkend en goed gespreid zorglandschap. Doelt u met het laatste op de regionale woonzorgvisie? Zo ja, waar kunnen aanbieders deze visie vinden? Zo nee, wat bedoelt u dan?	1.1
U spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het gebruik van de Milieu Thermometer Zorg ten opzichte van andere manieren om duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk te maken. Aanbieders ontvangen ook alleen een vergoeding bij het gebruik van de Milieu Thermometer Zorg. Wij zijn van mening u hiermee een middel centraal stellen, in plaats van het doel om te verduurzamen. Wij verzoeken u daarom om ook aanbieders die hun duurzaamheidsinspanning op andere manieren inzichtelijk maken een vergoeding te bieden? Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	2.4.2
Kan het zorgkantoor verduidelijken of de genoemde toepassingen bedoeld zijn als voorbeelden van kansrijke werkwijzen, of als concrete verwachting richting alle Wlz-aanbieders? En als het laatste het geval is: op basis van welke onderbouwing, voor welke doelgroepen en met welke randvoorwaarden en bekostiging?	2.6.2.2
Hoe beoordeelt het zorgkantoor of de innovatie bewezen effectief is? Wordt daarbij ook rekening gehouden met medewerkers- en clienttevredenheid, administratieve lastenverlichting, etc.?	2.6.2.2

Wij onderschrijven dat de genoemde innovaties veelbelovend kunnen zijn, mits zij zorgvuldig en contextafhankelijk worden geïmplementeerd. Wij zijn het echter niet eens met de stelling dat deze innovaties reeds bewezen effectief zijn binnen de intramurale setting. Voor sommige innovaties, waaronder beeldzorg, wordt bovendien nog gewerkt aan een gezamenlijk standpunt. Daarmee achten wij het te stellig om deze innovaties te presenteren als overal bewezen effectief, overal toepasbaar of zonder meer verplichtend. Wij verzoeken het zorgkantoor deze nuance expliciet in de passage te verwerken. Is het zorgkantoor bereid de passage op dit punt aan te passen? Zo nee, waarom niet?	2.6.2.2
U geeft aan dat keuzes worden gemaakt in concentratie en spreiding, waarbij het uitgangspunt is: "lokaal wat kan en regionaal wat moet". Op welke wijze worden zorgaanbieders betrokken bij de besluitvorming over deze keuzes in concentratie en spreiding in de regio?	4.1
Er wordt gesproken over een verouderd beeld van de (ouderen)zorg, waardoor voorlichting en ondersteuning essentieel zijn. Waar doelt het zorgkantoor op en kunnen aanbieders concrete acties verwachten van het zorgkantoor die deze beeldvorming bij moeten stellen?	4.1
U geeft aan dat keuzes worden gemaakt in concentratie en spreiding, waarbij het uitgangspunt is: "lokaal wat kan en regionaal wat moet". Kunt u toelichten welke concrete keuzes in dit kader worden gemaakt en op basis van welke criteria deze tot stand komen?	4.1
In uw beleid wordt uitgebreid ingegaan op de rol van "zorg thuis partners". Wordt hiermee beoogd om de zorgverlening voor de komende drie jaar vast te leggen bij een geselecteerde groep aanbieders?	4.3
U spreekt over de regionale woonzorgvisie. Waar kunnen zorgaanbieders deze visie vinden?	4.3.2
Doelt u met de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten in combinatie met de benodigde leveringsmix op de regiomonitor? Zo ja, hoe verhoudt de regiomonitor zich tot de regionale woonzorgvisie? Zo nee, wat bedoelt u dan wel en hoe verhouden de monitor en visie zich tot elkaar?	4.3.2
In de alinea "Introductiegesprek" staat dat de conclusie van het gesprek wordt vastgelegd in het zorgdossier van de cliënt. In het toetsingskader wordt aangegeven dat de overwegingen die tot deze keuze hebben geleid worden vastgelegd. Welke elementen wil Zorgkantoor Menzis terugzien in het dossier: enkel de conclusie of ook de overweging?	4.3.2
In uw beleid beschrijft u: "Omdat mpt in principe voorliggend is, wordt ongeclusterd vpt alleen in uitzonderingssituaties afgesproken. Deze werkwijze geldt in afwachting van de beoogde wetswijziging op dit punt."	4.3.2

Klopt de veronderstelling dat Menzis met 'uitzonderingssituaties' en 'deze werkwijze' verwijst naar het landelijke toetsingskader?	
Met betrekking tot het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd', veronderstellen wij dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de WLZ? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	4.3.2
Kunt u bevestigen of zorgaanbieders vanaf 2027 de principes mogen toepassen die Zorgkantoor DSW hanteert in de 'Pilot verminder gebruik AAT en rekenmodule'?	4.3.2
Bent u het er mee eens als wij als zorgaanbieder vanaf 2027 de principes gaan toepassen zoals Zorgkantoor DSW deze hanteert in de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dat betekent dat wij voor cliënten met MPT alleen een AAT in dienen als er een nieuwe aanbieder bij de zorg wordt betrokken, of als de leveringsvorm wijzigt, of als de zorg niet verantwoord geleverd kan worden. Zo nee, waarom niet?	
Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	4.3.2
De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	4.3.2
U formuleert in het beleid diverse randvoorwaarden voor extramuralisering. Kunt u toelichten wat het zorgkantoor hier tegenover zet voor zorgaanbieders?	4.3.2
U formuleert in het beleid diverse randvoorwaarden voor extramuralisering. Welke consequenties stelt het zorgkantoor op het moment dat het zorgaanbieders niet lukt dit te bewerkstelligen of de beoogde doelstellingen niet worden behaald?	4.3.2
Wat beoogt het zorgkantoor te bereiken met het selecteren van zorg thuis partners? Heeft het zorgkantoor hiermee als doel om de markt op het gebied van Wlz zorg thuis kleiner te maken?	4.3.2
Kunt u bevestigen dat de aanvullende afspraak voor zorg thuis partners uitgaat van vergoeding tegen 100% van het NZa-tarief, zonder toepassing van het vertrektarief of andere tariefkortingen of afslagen? Zo nee, waarom niet?	4.3.2
Wanneer Zorgkantoor Menzis spreekt over 'het kwaliteitsbeeld' wordt hiermee dan het kwaliteitsbeeld bedoeld dat zorgaanbieders in het kader van het Generiek Kompas opstellen?	4.3.2
Zorgkantoor Menzis hanteert een viertal beoordelingscriteria. Zowel in het document Zorginkoopbeleid Langdurige Zorg als in bijlage A Aanvullende financiering inkoopdoelen wordt verwezen naar pagina 47 voor wat betreft het kopje "Borging Toegankelijkheid". Echter in het Zorginkoopbeleid Langdurige Zorg wordt op pagina 47 gesproken over het tarief en bijlage A kent geen pagina 47. Kunt u dit toelichten?	4.3.3

U geeft aan dat een betere balans inhoudt dat de verdeling van de beschikbare (intramurale) capaciteit over gemeenten minder scheef is in verhouding tot het aandeel 75-plussers, dat cliënten verpleeghuiszorg binnen een redelijke afstand van hun huidige woonsetting kunnen ontvangen en dat het totale zorgaanbod (dus intra- en extramuraal) aansluit bij de (toekomstige) zorgvraag en demografische ontwikkelingen per gemeente. Kunt u toelichten wanneer volgens u sprake is van een 'in balans-situatie' en op basis van welke criteria deze beoordeling wordt gemaakt?	4.4.1
Kunt u onderbouwen waarop de conclusie is gebaseerd dat er momenteel sprake is van een onevenwichtige situatie in de regionale balans?	4.4.2
U stelt dat om te komen tot meer balans in de regio het noodzakelijk kan zijn dat zorgaanbieders maatregelen treffen in hun vastgoedportefeuille, zoals het afbouwen, verbouwen of herpositioneren van vastgoed. Kunt u aangeven welke concrete keuzes zorgaanbieders hierin volgens u kunnen maken en in welke mate het zorgkantoor hierop poogt te sturen? Wij veronderstellen namelijk dat zorgaanbieders een eigen integrale verantwoordelijk hebben.	4.4.2
Kunt u toelichten waarom deze maatregelen in deze fase moeten worden getroffen en welke onderbouwing hieraan ten grondslag ligt?	4.4.2
U geeft aan dat u vanuit de rol van regiehouder op de regionale capaciteit en het streven naar een dekkend zorglandschap op basis daarvan concrete afspraken maakt met individuele zorgaanbieders. Kunt u toelichten waarom deze afspraken niet primair in regionaal verband met meerdere zorgaanbieders gezamenlijk worden besproken?	4.4.2
U geeft aan dat het van belang is dat elke zorgaanbieder reflecteert op de bijdrage die zij kan leveren aan het oplossen van het regionale capaciteitsvraagstuk en de rol die zij hierin kan vervullen. Kunt u toelichten op welk concreet capaciteitsvraagstuk hier wordt gedoeld?	4.4.2
In het inkoopbeleid staat dat u financiering beschikbaar stelt voor 'Inzet van regiebehandeling voor cliënten in de thuissituatie'. Kunt u toelichten wat hier precies onder wordt verstaan?	3.6.1.2
Wat beoogt u te bereiken door de herijkte capaciteit op te nemen in het addendum?	4.4.3
Hoe verhoudt de herijkte capaciteit zich tot de landelijk vastgestelde intramurale verpleeghuiscapaciteit van 130.000 plekken?	4.4.3
Welke gevolgen kunnen voortvloeien uit een afwijking tussen de herijkte capaciteit en de landelijk vastgestelde intramurale capaciteit voor zorgaanbieders en de zorgplicht van zorgkantoren?	4.4.3
U geeft aan dat vooralsnog wordt verwacht dat met een iets lagere capaciteit aan de intramurale zorgvraag kan worden voldaan. Wij zien hierin echter een potentieel risico. Kunt u toelichten hoe zorgkantoor Menzis voornemens is de intramurale capaciteit weer op te bouwen indien	4.4.3

de zorgvraag zich anders ontwikkelt dan momenteel wordt verwacht en alsnog toeneemt?	
Hoe verhouden de eisen van Menzis omtrent een strategisch vastgoedplan tot de eigen integrale verantwoordelijkheid van zorgaanbieders?	4.4.2
In het inkoopbeleid geeft u aan dat kwaliteit van de Wlz zorg thuis terug dient te komen in het kwaliteitsbeeld. Onder het Generiek Kompas is een jaarlijks vormvrij kwaliteitsbeeld afgesproken, waar geen vaste thema's zijn afgesproken. Kunt u bevestigen dat u geen aanvullende acties van zorgaanbieders vereist die méér of extra vragen dan volgt uit de afspraken van het Generiek Kompas? Zo nee, waarom niet?	4.3.2
Op meerdere plekken in het inkoopbeleid worden thema's benoemd die aan de orde komen tijdens de bespreking van het kwaliteitsbeeld (open-deuren beleid, kwaliteit van Wlz zorg thuis, ondersteuning van medewerkers voor specifieke doelgroepen, cultuur sensitieve zorg, transitie naar complexere intramurale zorg). U geeft hierbij aan dat bij onvoldoende zicht hierop de zorgaanbieder om een toelichting wordt gevraagd. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend gaat om een mondelinge toelichting, u geen aanvullende informatie opvraagt en u niet verplicht deze thema's onderdeel te maken van het kwaliteitsbeeld? Zo nee, waarom niet?	4.3.2
In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat de beoordeling of een zorgaanbieder als 'zorg-thuis-partner' kan worden aangemerkt, mede afhankelijk is van de invulling van de rol op het gebied van MGZ. Kunt u toelichten hoe deze voorwaarde zich verhoudt tot de positie van compactere zorgaanbieders? Onzes inziens bestaat het risico dat deze aanbieders minder snel voor deze rol in aanmerking komen vanwege hun beperkte mogelijkheden om invulling te geven aan de MGZ-functie.	4.3.3
Zorgkantoor Menzis spreekt over een besluit over de betreffende capaciteit in een volgende beleidsperiode. Kunt u verduidelijken wat wordt verstaan onder 'een volgende beleidsperiode'?	4.4.3
U geeft aan dat sommige doelgroepen die in de periode 2024 - 2026 nog werden gekenmerkt als specifieke doelgroep, niet langer specifiek worden ingekocht. Kunt u toelichten welke overwegingen ten grondslag liggen aan deze wijziging?	4.5.1
U beschrijft dat u de analyse van het zorglandschap voor specifieke doelgroepen deelt aan de regionale bestuurlijke tafels, zodat waar nodig samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden om een passend en dekkend regionaal aanbod te borgen. Welke rol vervult het zorgkantoor na het delen van deze analyse?	4.5.2
In het inkoopbeleid wordt gesteld dat de zorgaanbieder ambassadeur is van het innovatietraject. Kunt u verduidelijken of Menzis hierin wel cofinanciering beschikbaar stelt voor de innovatie? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten waarom ervoor gekozen is geen financiële bijdrage te leveren aan deze trajecten? Andere zorgkantoren hanteren voor innovatieprojecten immers wel vormen van cofinanciering.	4.6.2.1

U geeft aan initiatieven te steunen en graag actief mee te denken over mogelijkheden die de onnodige administratieve druk voor zorgaanbieders verminderen. Kunt u aangeven welke concrete maatregelen het zorgkantoor Menzis zelf neemt om de administratieve druk te verlagen?	4.6.2.3
In het document wordt gesteld dat het verfijnde model voor tariefdifferentiatie wordt ingevoerd "om meer recht te doen aan verschillen tussen zorgaanbieders zoals gevraagd door de branches". Wij herkennen ons niet in deze weergave. Voor zover ons bekend hebben de brancheorganisaties niet verzocht om de invoering van dit specifieke model of om verdere tariefdifferentiatie op de wijze zoals nu wordt voorgesteld. Wij verzoeken u daarom deze passage te verwijderen dan wel aan te passen, tenzij u kunt onderbouwen welke brancheorganisaties dit verzoek hebben gedaan. Zonder deze onderbouwing wekt de huidige formulering ten onrechte de indruk dat er vanuit de branches draagvlak bestaat voor deze wijziging. Bent u bereid tot deze wijziging? Zo nee, waarom niet?	5.1
'Zorgaanbieders in een groep leveren dezelfde zorg en hebben een vergelijkbare bedrijfsvoering op basis van objectieve kenmerken.' Kunt u toelichten wat deze 'objectieve kenmerken' zijn?	5.1
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	5.2
Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan de gehanteerde afslag van 2% voor nieuwe zorgaanbieders?	5.2
U geeft aan dat als zorgaanbieders capaciteit afbouwen, deze komt te vervallen, tenzij in afstemming met het zorgkantoor een concrete herbestemming is voorzien. Wij zien hierin een potentieel risico. Kunt u toelichten hoe zorgkantoor Menzis voornemens is de intramurale capaciteit weer op te bouwen indien de zorgvraag zich anders ontwikkelt dan momenteel wordt verwacht en alsnog toeneemt?	4.4.2
U geeft aan dat landelijk leegstand in verpleeghuizen ontstaat. Dit beeld herkennen wij niet; volgens de monitor van ActiZ over bedbezetting is leegstand sterk afhankelijk van regionale en lokale omstandigheden en niet zonder meer als landelijk fenomeen te duiden. Hierover loopt bovendien nog een onderzoek bij het RIVM. Kunt u onderbouwen op welke data of analyses deze constatering van landelijke leegstand is gebaseerd?	4.4.2
In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat Menzis Zorgkantoor op de website definities zal publiceren van gehanteerde begrippen, waaronder 'ongeclusterde en geclusterde leveringsvormen' en 'vastgestelde verpleeghuiscapaciteit'. Wij constateren dat deze definities nog niet volledig online beschikbaar zijn. Wanneer worden deze definities online beschikbaar gesteld?	4.4.3

In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat Menzis Zorgkantoor op de website definities zal publiceren van gehanteerde begrippen, waaronder 'ongecclusterde en gecclusterde leveringsvormen' en 'vastgestelde verpleeghuiscapaciteit'. Wordt bij de totstandkoming en publicatie van deze definities afgestemd met de andere zorgkantoren, zodat eenduidigheid in de begrippen wordt geborgd? Zo nee waarom niet? Wij achten het zeer onwenselijk wanneer zorgkantoren uiteenlopende definities hanteren voor dezelfde begrippen.	4.4.3
Kunt u bevestigen dat het HLO-regiobudget aangevraagd kan worden voor de doelen zoals geformuleerd in het landelijk beleid over dit budget? Zo nee, waarom niet?	4.6.1.3
In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat Menzis Zorgkantoor voornemens is om in de beleidsperiode 2027–2029 samen te werken met een externe partij met als doel zorgaanbieders die samen innoveren te ondersteunen bij het aantonen van effecten, uitkomsten en inzichten van innovatietrajecten. Kunt u toelichten wat deze ondersteuning concreet inhoudt, welke rol de externe partij hierin vervult en op welke wijze zorgaanbieders hiervan gebruik kunnen maken?	4.6.2.3
U geeft aan in gesprek te gaan met zorgaanbieders die een hoog positief resultaat behalen over de mogelijkheden om een lager tarief af te spreken. Kunt u verduidelijken wat u onder 'een hoog positief' verstaat? En kunt u vervolgens toelichten op welke analyses de keuze voor deze grens is gebaseerd en welke betekenis aan deze grens wordt toegekend bij de beoordeling of een gesprek over het tarief plaatsvindt?	5.3
Kunt u toelichten hoe wordt omgegaan met zorgaanbieders waarvan het rendement zich rond de door het zorgkantoor gehanteerde grens bevindt en hoe een consistente toepassing wordt geborgd?	5.3
Kunt u toelichten welke mogelijke uitkomsten het genoemde gesprek bij 'een hoog positief resultaat' kan hebben en in hoeverre het zorgkantoor daarbij beleidsruimte heeft om het tarief aan te passen?	5.3
Kunt u toelichten welke afwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de keuze om bij 'een hoog positief resultaat' een gesprek over het tarief te voeren, mede in het licht van investeringen en continuïteit van zorg?	5.3
Kunt u bevestigen dat het rendement wordt berekend als het nettoresultaat gedeeld door de som der bedrijfsopbrengsten, en toelichten waarom dit totale ondernemingsrendement wordt gehanteerd als criterium bij de beoordeling of een gesprek over het tarief wordt gevoerd?	5.3
Kunt u toelichten over welke periode het rendement wordt vastgesteld en op basis van welke financiële gegevens?	5.3
Er staat dat Menzis Zorgkantoor gerechtigd is de Wet BiBob eveneens toe te passen gedurende de looptijd van de overeenkomst als zich feiten en omstandigheden voordoen die naar de mening van Menzis Zorgkantoor aanleiding geven om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Kunt u toelichten welke feiten en omstandigheden dit zijn?	6.1.3

U beschrijft dat als er wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de gegevens en/of inschrijvingsdocumenten die ten grondslag lagen aan de laatste contracteringsronde, deze wijzigingen gemeld dienen te worden en eventueel gewijzigde documenten aangeleverd moeten worden. Kunt u toelichten hoe deze gegevens aangeleverd dienen te worden? Uit deze paragraaf blijkt niet of dit via Veocozo gedaan dient te worden.	6.5
In het inkoopbeleid zien wij geen verwijzing naar de toepassing van de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking ten behoeve van de regionale transformatie. Kunt u toelichten wat uw visie en beleid zijn ten aanzien van de wet DOS en om welke reden dit geen expliciete plaats heeft gekregen in het inkoopbeleid?	Generiek
Met ingang van 1 januari 2026 is de wet Domein overstijgende samenwerking (DOS) in werking getreden. Wanneer maakt het zorgkantoor het DOS-beleid bekend met de voorwaarden voor nieuwe projecten en de continuering van de bestaande projecten?	Generiek

Zorgkantoor VGZ

Vraag	Paragraaf
Het inkoopbeleid Langdurige zorg 2027–2029 is in één integrale publicatie voor alle sectoren opgenomen. Voor zorgaanbieders in de uitvoering is dit echter minder overzichtelijk en minder werkbaar. Wij verzoeken het zorgkantoor om hier drie aparte publicaties van te maken. Kan het zorgkantoor hiermee in stemmen? Zo nee, op basis van welke overwegingen is gekozen voor één gecombineerde publicatie?	Generiek
Wij merken op dat Zorgkantoor VGZ in haar inkoopbeleid niet verwijst naar het landelijke beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd' en de toepassing van het daarbij behorende landelijke toetsingskader. Wij nemen aan dat het Zorgkantoor wel aansluit bij dit landelijke beleid. Kunt u dit bevestigen? Zo nee waarom niet?	Generiek
Met betrekking tot het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd', veronderstellen wij dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de Wlz? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	Generiek
Kunt u bevestigen of zorgaanbieders vanaf 2027 de principes mogen toepassen die Zorgkantoor DSW hanteert in de 'Pilot verminder gebruik AAT en rekenmodule'? Bent u het er mee eens als wij als zorgaanbieder vanaf 2027 de principes gaan toepassen zoals Zorgkantoor DSW deze hanteert in de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dat betekent dat wij voor cliënten met MPT alleen een AAT in dienen als er een nieuwe aanbieder bij de zorg wordt betrokken, of als de leveringsvorm wijzigt, of als de zorg niet verantwoord geleverd kan worden. Zo nee, waarom niet?	Generiek

Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	Generiek
De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	Generiek
Het inkoopbeleid is onlosmakelijk verbonden aan de regioplannen. Kunt u aangeven wanneer de regioplannen worden gepubliceerd, zodat zorgaanbieders bij de inschrijving tijdig kunnen beoordelen op welke wijze aansluiting kan worden gevonden bij deze plannen?	Generiek
In uw inkoopbeleid kunnen wij geen toelichting vinden op de NHC/NIC. Wij nemen aan dat aanbieders, net als bij de andere zorgkantoren, een 100% vergoeding ontvangen. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?	Generiek
In het voorwoord wordt gesproken over heldere kaders. Wij constateren echter dat de nieuwe tariefsystematiek leidt tot grote onzekerheid. Hiermee zijn de kaders voor ons als aanbieder niet duidelijk. Hoe zorgt het zorgkantoor ervoor dat de kaders, ook financieel, helder zijn voor de komende jaren? Als aanbieders hebben wij immers een bepaalde mate van financiële zekerheid en stabiliteit nodig.	Voorwoord p.3
Kan het zorgkantoor verduidelijken of de genoemde toepassingen bedoeld zijn als voorbeelden van kansrijke werkwijzen, of als concrete verwachting richting alle Wlz-aanbieders? En als het laatste het geval is: op basis van welke onderbouwing, voor welke doelgroepen en met welke randvoorwaarden en bekostiging?	2
Hoe beoordeelt het zorgkantoor of de innovatie bewezen effectief is? Wordt daarbij ook rekening gehouden met medewerkers- en clienttevredenheid, administratieve lastenverlichting, etc.?	2
Wij onderschrijven dat de genoemde innovaties veelbelovend kunnen zijn, mits zij zorgvuldig en contextafhankelijk worden geïmplementeerd. Wij zijn het echter niet eens met de stelling dat deze innovaties reeds bewezen effectief zijn binnen de intramurale setting. Voor sommige innovaties, waaronder beeldzorg, wordt bovendien nog gewerkt aan een gezamenlijk standpunt. Daarmee achten wij het te stellig om deze innovaties te presenteren als overall bewezen effectief, overall toepasbaar of zonder meer verplichtend. Wij verzoeken het zorgkantoor deze nuance expliciet in de passage te verwerken. Is het zorgkantoor bereid de passage op dit punt aan te passen? Zo nee, waarom niet?	2
Kan het zorgkantoor de wens voor semi-geclusterde zorg, ten opzichte van geclusterde extramurale zorg, onderbouwen?	2.1
Het zorgkantoor geeft aan de voorkeur te hebben voor semi-geclusterde zorg. Kunt u toelichten hoe zorgaanbieders in deze situatie dienen om te	2.1

gaan met de behandelcomponent? Dient deze in dat geval als extramurale zorg met behandeling te worden georganiseerd?	
"VGZ Zorgkantoor hanteert geen vaste procentuele norm, maar beoordeelt op basis van de dominante wijze waarop de zorg feitelijk wordt georganiseerd". Kunt u toelichten wat hiermee wordt bedoeld?	2.1
Hoe verhouden de eisen van Zorgkantoor VGZ omtrent een strategisch vastgoedplan tot de eigen integrale verantwoordelijkheid van zorgaanbieders?	2.1
"Voor aanbieders in de V&V geldt dat VGZ Zorgkantoor op voorhand geen uitbreiding toestaat van geclusterd VPT. Uitsluitend wanneer sprake is van herbestemming van intramuraal vastgoed kan hiernaar worden gekeken. VGZ Zorgkantoor streeft naar af- en ombouw van intramurale capaciteit (circa 5% afname in de periode 2027-2031)." Wij zien een risico in het afbouwen van intramurale capaciteit. Kunt u toelichten hoe zorgkantoor VGZ voornemens is de intramurale capaciteit weer op te bouwen indien de zorgvraag zich anders ontwikkelt dan momenteel wordt verwacht en alsnog toeneemt?	2.1
"Voor aanbieders in de V&V geldt dat VGZ Zorgkantoor op voorhand geen uitbreiding toestaat van geclusterd VPT. Uitsluitend wanneer sprake is van herbestemming van intramuraal vastgoed kan hiernaar worden gekeken. VGZ Zorgkantoor streeft naar af- en ombouw van intramurale capaciteit (circa 5% afname in de periode 2027-2031)." Kan het zorgkantoor toelichten waarom er geen uitbreiding meer plaats mag vinden in de vorm van geclusterd VPT?	2.1
In hoeverre biedt het zorgkantoor zorgaanbieders in de regio ruimte om gezamenlijk de beschikbare capaciteit en eventuele regionale afspraken te bespreken?	2.1
In het inkoopbeleid wordt gesproken over "voldoende bevoegde en gemotiveerde medewerkers". Op welke wijze heeft zorgkantoor VGZ 'bekwaam is bevoegd' verankerd in het beleid?	2.2
In het document wordt gesteld dat het verfijnde model voor tariefdifferentiatie wordt ingevoerd "om meer recht te doen aan verschillen tussen zorgaanbieders zoals gevraagd door de branches". Wij herkennen ons niet in deze weergave. Voor zover ons bekend hebben de brancheorganisaties niet verzocht om de invoering van dit specifieke model of om verdere tariefdifferentiatie op de wijze zoals nu wordt voorgesteld. Wij verzoeken u daarom deze passage te verwijderen dan wel aan te passen, tenzij u kunt onderbouwen welke brancheorganisaties dit verzoek hebben gedaan. Zonder deze onderbouwing wekt de huidige formulering ten onrechte de indruk dat er vanuit de branches draagvlak bestaat voor deze wijziging. Bent u bereid tot deze wijziging? Zo nee, waarom niet	3.2
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	3.2

Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan de gehanteerde afslag van 2% voor nieuwe zorgaanbieders?	3.2
"Aanbieders in een groep leveren dezelfde zorg en hebben een vergelijkbare bedrijfsvoering op basis van objectieve kenmerken." Kunt u toelichten wat deze 'objectieve kenmerken' zijn?	3.2
Kan het zorgkantoor bevestigen dat zorgaanbieders binnen alle drie de lijnen van de tariefsystematiek financiering kunnen ontvangen? De toelichting in Hfst. 3.3 is voor ons onvoldoende duidelijk en te vaag geformuleerd.	3.3
Kan het zorgkantoor nader toelichten wat wordt verstaan onder cofinanciering?	3.3
De opslag voor toename van digitale zorg wordt door Zorgkantoor VGZ beperkt door deze uitsluitend te koppelen aan MPT-tarieven. Ook binnen VPT- en ZZP-zorgvormen worden cliënten ondersteund met digitale zorg. Kan het zorgkantoor toelichten wat de reden is om de opslag uitsluitend aan MPT-tarieven te koppelen? En kan het zorgkantoor bevestigen of deze opslag ook kan worden toegekend aan VPT- en ZZP-aanbieders? Indien dit niet mogelijk is, kunt u een toelichting geven op de achterliggende overwegingen?	3.3
Kunt u concreet toelichten wat binnen het zorginkoopbeleid (kopje passend tarief) wordt verstaan onder een "bijdrage in de regio" van een zorgaanbieder?	3.3
Kunt u inzichtelijk maken op basis van welke criteria de regionale bijdrage van zorgaanbieders wordt beoordeeld?	3.3
Kunt u toelichten hoe de beoordeling van de regionale bijdrage doorwerkt in de uiteindelijke tariefafspraken, bijvoorbeeld in termen van bandbreedtes of richtlijnen?	3.3.
Kunt u toelichten hoe wordt geborgd dat zorgaanbieders met vergelijkbare bijdragen in de regio op een vergelijkbare wijze worden beoordeeld bij de tariefafspraken?	3.3
Kunt u toelichten welke belangen zijn meegewogen bij het betrekken van de regionale bijdrage bij de tariefafspraken?	3.3
Kunt u toelichten welke mogelijke gevolgen het overleg over het passend tarief kan hebben voor de uiteindelijke tariefafspraken, indien partijen geen overeenstemming bereiken?	3.3
U stelt: In de situaties waar sprake is van hoge rendementen (>5%) gaan wij het gesprek met de zorgaanbieder aan om te onderzoeken of dit aanleiding is om gezamenlijk een lager tarief af te spreken. Kunt u bevestigen dat het rendement van >5% wordt berekend als het nettoresultaat gedeeld door de som der bedrijfsopbrengsten, en toelichten waarom dit totale ondernemingsrendement wordt gehanteerd als criterium bij de beoordeling of een gesprek over het tarief wordt gevoerd?	3.3

U stelt: In de situaties waar sprake is van hoge rendementen (>5%) gaan wij het gesprek met de zorgaanbieder aan om te onderzoeken of dit aanleiding is om gezamenlijk een lager tarief af te spreken. Kunt u toelichten over welke periode het rendement wordt vastgesteld en op basis van welke financiële gegevens?	3.3
U stelt: In de situaties waar sprake is van hoge rendementen (>5%) gaan wij het gesprek met de zorgaanbieder aan om te onderzoeken of dit aanleiding is om gezamenlijk een lager tarief af te spreken. Kunt u toelichten op welke analyses de keuze voor een vaste grens van 5% is gebaseerd en welke betekenis aan deze grens wordt toegekend bij de beoordeling of een gesprek over het tarief plaatsvindt?	3.3
U stelt: In de situaties waar sprake is van hoge rendementen (>5%) gaan wij het gesprek met de zorgaanbieder aan om te onderzoeken of dit aanleiding is om gezamenlijk een lager tarief af te spreken. Kunt u toelichten hoe wordt omgegaan met zorgaanbieders waarvan het rendement zich rond de 5%-grens bevindt (bijvoorbeeld 4,9% of 5,1%) en hoe een consistente toepassing wordt geborgd?	3.3
U stelt: In de situaties waar sprake is van hoge rendementen (>5%) gaan wij het gesprek met de zorgaanbieder aan om te onderzoeken of dit aanleiding is om gezamenlijk een lager tarief af te spreken. Kunt u toelichten welke mogelijke uitkomsten het genoemde gesprek bij een rendement boven 5% kan hebben en in hoeverre het zorgkantoor daarbij beleidsruimte heeft om het tarief aan te passen?	3.3
U stelt: In de situaties waar sprake is van hoge rendementen (>5%) gaan wij het gesprek met de zorgaanbieder aan om te onderzoeken of dit aanleiding is om gezamenlijk een lager tarief af te spreken. Kunt u toelichten welke afwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de keuze om bij een rendement boven 5% een gesprek over het tarief te voeren, mede in het licht van investeringen en continuïteit van zorg?	3.3
Wij missen de relatie tot de inkoop- en tariefsystematiek in deze passage. Kunt u toelichten wat het betekent als de ratio van 3 niet wordt behaald in sub-regio's?	3.6
Wij missen de relatie tot de inkoop- en tariefsystematiek in deze passage. Kunt u toelichten welke Zvw-declaratiegegevens worden meegenomen in de beoordeling, mede gezien het feit dat ook systeemfuncties in de declaraties zijn opgenomen die buiten het kerngebied van de organisatie vallen.	3.6
Hoe dienen zorgaanbieders de genoemde overeenkomstopties te interpreteren in relatie tot de tariefsystematiek op de verschillende lijnen (pagina 22), aangezien hierin geen verwijzing wordt gemaakt naar tweejarige overeenkomsten?	4.4
Met ingang van 1 januari 2026 is de wet Domein overstijgende samenwerking (DOS) in werking getreden. Wanneer maakt het	Generiek

zorgkantoor het DOS-beleid bekend met de voorwaarden voor nieuwe projecten en de continuering van de bestaande projecten?	
In het inkoopbeleid zien wij geen verwijzing naar de toepassing van de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking ten behoeve van de regionale transformatie. Kunt u toelichten wat uw visie en beleid zijn ten aanzien van de wet DOS en om welke reden dit geen expliciete plaats heeft gekregen in het inkoopbeleid?	Generiek

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Vraag	Paragraaf
'We nodigen Wlz-behandeldiensten en huisartsen uit om samen te bespreken hoe we de MGZ voor Wlz-cliënten verder kunnen verbeteren.' Kunt u toelichten of Zorgkantoor Zorg & Zekerheid in gesprek gaat met behandeldiensten of met Wlz-zorgaanbieders?	4.1
Sinds 1 juli 2024 is het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan van kracht voor de VV. Het Generiek Kompas heeft kwaliteit van bestaan als uitgangspunt. Is er een reden waarom er in uw inkoopbeleid is afgeweken van het taalgebruik van het Generiek Kompas (kwaliteitskader in plaats van het Generiek Kompas)?	Overzicht aan te leveren documenten voor nieuwe zorgaanbieders – p.33
U spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het gebruik van de Milieu Thermometer Zorg ten opzichte van andere manieren om duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk te maken. Aanbieders ontvangen ook alleen een vergoeding bij het gebruik van de Milieu Thermometer Zorg. Wij zijn van mening u hiermee een middel centraal stellen, in plaats van het doel om te verduurzamen. Wij verzoeken u daarom om ook aanbieders die hun duurzaamheidsinspanning op andere manieren inzichtelijk maken een vergoeding te bieden? Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	4.1
U stelt dat "wanneer bij VPT de kosten minder dan 80% van de inkomsten bedragen, MPT altijd de beste passende leveringsvorm is". Naar onze mening doet deze algemene voorwaarden de andere criteria teniet. Het financiële criterium zou nevensgeschikt moeten zijn en niet bovengeschild aan de overige criteria. Er kan sprake zijn van cliënten die tegen de 80% grens aanzitten, maar ook een complexe instabiele zorgvraag hebben met hoge administratieve lasten. Dit kan ongewenste grensgevallen opleveren waarin doelmatigheid boven zorginhoudelijke argumenten gaat. Wij verzoeken om het 80% criterium niet bovengeschild te maken, maar toe te voegen aan criterium vier. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?	4.2.1
Met betrekking tot het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd', veronderstellen wij dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de WLZ? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	4.2.1
Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	4.2.1

De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	4.2.1
Kunt u bevestigen of zorgaanbieders vanaf 2027 de principes mogen toepassen die Zorgkantoor DSW hanteert in de 'Pilot verminder gebruik AAT en rekenmodule'?	4.2.1
Bent u het er mee eens als wij als zorgaanbieder vanaf 2027 de principes gaan toepassen zoals Zorgkantoor DSW deze hanteert in de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dat betekent dat wij voor cliënten met MPT alleen een AAT in dienen als er een nieuwe aanbieder bij de zorg wordt betrokken, of als de leveringsvorm wijzigt, of als de zorg niet verantwoord geleverd kan worden. Zo nee, waarom niet?	
U geeft aan dat landelijk leegstand in verpleeghuizen ontstaat. Dit beeld herkennen wij niet; volgens de monitor van ActiZ over bedbezetting is leegstand sterk afhankelijk van regionale en lokale omstandigheden en niet zonder meer als landelijk fenomeen te duiden. Hierover loopt bovendien nog een onderzoek bij het RIVM.	4.2.1
Kunt u onderbouwen op welke data of analyses deze constatering van landelijke leegstand is gebaseerd?	
In het document wordt gesteld dat het verfijnde model voor tariefdifferentiatie wordt ingevoerd "om meer recht te doen aan verschillen tussen zorgaanbieders zoals gevraagd door de branches". Wij herkennen ons niet in deze weergave. Voor zover ons bekend hebben de brancheorganisaties niet verzocht om de invoering van dit specifieke model of om verdere tariefdifferentiatie op de wijze zoals nu wordt voorgesteld.	5.1
Wij verzoeken u daarom deze passage te verwijderen dan wel aan te passen, tenzij u kunt onderbouwen welke brancheorganisaties dit verzoek hebben gedaan. Zonder deze onderbouwing wekt de huidige formulering ten onrechte de indruk dat er vanuit de branches draagvlak bestaat voor deze wijziging. Bent u bereid tot deze wijziging? Zo nee, waarom niet?	
"Aanbieders in een groep leveren dezelfde zorg en hebben een vergelijkbare bedrijfsvoering op basis van objectieve kenmerken."	5.1
Kunt u toelichten wat deze 'objectieve kenmerken' zijn?	
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	5.1
Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan de gehanteerde afslag van 2% voor nieuwe zorgaanbieders?	5.2
Met ingang van 1 januari 2026 is de wet Domein overstijgende samenwerking (DOS) in werking getreden. Wanneer maakt het zorgkantoor het DOS-beleid bekend met de voorwaarden voor nieuwe projecten en de continuering van de bestaande projecten?	Generiek
Domeinoverstijgende Samenwerking ten behoeve van de regionale transformatie.	Generiek

Kunt u toelichten wat uw visie en beleid zijn ten aanzien van de wet DOS en om welke reden dit geen expliciete plaats heeft gekregen in het inkoopbeleid?	
---	--

Zorgkantoor DSW

Vraag	Paragraaf
Kunt u aangeven wat de eisen en voorwaarden zijn rondom de Hardheidsclausule? Deze kunnen wij niet terugvinden in uw inkoopbeleid.	Generiek
Sinds 1 juli 2024 is het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan van kracht voor de VV. Het Generiek Kompas heeft kwaliteit van bestaan als uitgangspunt. Is er een reden waarom er in uw inkoopbeleid is afgeweken van het taalgebruik van het Generiek Kompas (kwaliteitskader in plaats van het Generiek Kompas)?	1.4
In het inkoopbeleid beschrijft Zorgkantoor DSW dat in lijn met het HLO MPT voorliggend is aan VPT. In het HLO is echter afgesproken dat het MPT in principe voorliggend is aan het VPT ongeclusterd . In uw inkoopbeleid ontbreken de termen 'in principe' en 'ongeclusterd'. Kan het zorgkantoor deze termen toevoegen aan deze passage?	2.2
In het inkoopbeleid verwijst u naar het toetsingskader voor het beleid rondom MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd. Wij nemen aan dat aanbieders dit toetsingskader alleen in hoeven te zetten voor nieuwe cliënten, aansluitend bij de afspraken uit het HLO. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?	2.2
De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	2.2
In het inkoopbeleid beschrijft Zorgkantoor DSW dat in lijn met het HLO MPT voorliggend is aan VPT. Wij nemen aan dat Zorgkantoor DSW aansluit bij het landelijke beleid 'MPT in principe voorliggend op het VPT ongeclusterd' en hierbij ook het landelijke toetsingskader toepast. Kan het zorgkantoor dit bevestigen?	2.2
Met betrekking tot het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd', veronderstellen wij dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de WLZ? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	2.2
Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	2.2
U stelt: Indien we om voorgaande redenen wel overgaan tot het contracteren van VPT dan zal dit tegen een sterk gereduceerd tarief zijn, wat als uitgangspunt kent dat de vergoeding per dag gelijk is aan hetgeen in MPT geleverd wordt. Kunt u toelichten op welke grondslag het Zorgkantoor meent een sterk gereduceerd tarief voor VPT te kunnen hanteren, aangezien een voorkeur	2.4

voor MPT ten opzichte van VPT het zorgkantoor niet ontslaat van de verplichting om een reëel en kostendekkend tarief te bieden?	
Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan het standaard tariefpercentage van 91% van het NZA-tarief voor nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders nieuw in de regio?	3.1
Met ingang van 1 januari 2026 is de wet Domein overstijgende samenwerking (DOS) in werking getreden. Wanneer maakt het zorgkantoor het DOS-beleid bekend met de voorwaarden voor nieuwe projecten en de continuering van de bestaande projecten?	3.4
Kunt u toelichten wat de oorzaak is van de vertraging in de publicatie van het beleid omtrent DOS, aangezien dit beleid ook nog betrekking heeft op 2026?	3.4
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	Bijlage 1
Kunt u toelichten op basis van welke gegevens, aannames en prognoses wordt vastgesteld dat sprake is, dan wel naar verwachting zal zijn, van krapte in het regiobudget of de contracteerruimte?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u toelichten op welk moment wordt beoordeeld of het regiobudget toereikend is (vooraftgaand aan het contractjaar, tijdens het jaar of achteraf)?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u verduidelijken wat DSW verstaat onder 'krapte in het regiobudget' en wanneer deze situatie volgens DSW gevolgen kan hebben voor contractering, volumeafspraken of tariefafspraken met zorgaanbieders?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u toelichten welke concrete consequenties DSW verbindt aan de vaststelling van (dreigende) budgetkrapte, in het bijzonder voor: • Tariefafspraken; • Volumeafspraken; en • Voortzetting of wijziging van bestaande contractafspraken?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u toelichten of en in hoeverre budgetkrapte aanleiding kan zijn voor het aanpassen of beperken van overeengekomen tarieven, en op basis van welke uitgangspunten en contractuele bepalingen dit plaatsvindt?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u toelichten of en op welke contractuele bepalingen DSW zich baseert indien zij meent dat budgetkrapte aanleiding kan zijn voor eenzijdige aanpassing van tarieven of volumes?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u toelichten of DSW bij de toepassing van budgetkrapte ook uitgaat van de mogelijkheid om tarief- of volumeaanpassingen met terugwerkende kracht toe te passen, en zo ja, vanaf welk moment en onder welke voorwaarden?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Kunt u toelichten op welk moment zorgaanbieders duidelijkheid krijgen over de eventuele gevolgen van budgetkrapte, zodat zij hun bedrijfsvoering, personeelsinzet en investeringen daarop kunnen afstemmen?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14

Kunt u toelichten op welke wijze zorgaanbieders inzicht krijgen in de vaststelling en toepassing van budgetkrapte, en welke mogelijkheden bestaan om hierop te reageren, dan wel bezwaar tegen te maken?	Bijlage 2 in contracteerbeleid – p.14
Zorgkantoor DSW verwacht van zorgaanbieders dat zij in lijn met de gedachte van de nog op te stellen opnametoets dienen te handelen. Wij veronderstellen dat u hiermee vooruitloopt op het nog nader uit te werken en vast te stellen afwegingskader. Welke vorm van controle voert het zorgkantoor uit op de naleving van deze verwachting?	p. 26 (bijlage 4 in Contracteerbeleid)

Zorgkantoor Salland

Vraag	Paragraaf
Sinds 1 juli 2024 is het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan van kracht voor de VV. Het Generiek Kompas heeft kwaliteit van bestaan als uitgangspunt. Is er een reden waarom er in uw inkoopbeleid is afgeweken van het taalgebruik van het Generiek Kompas (kwaliteitskader in plaats van het Generiek Kompas)?	1.4
Salland is voornemens om bestaande V&V-capaciteit in te zetten voor cliënten in de Ggz of Gz. Wij zien hierin een potentieel risico Kunt u toelichten hoe zorgkantoor Salland voornemens is de intramurale capaciteit weer op te bouwen indien de zorgvraag zich anders ontwikkelt dan momenteel wordt verwacht en alsnog toeneemt?	2.2
Zorgkantoor Salland verwacht van zorgaanbieders dat zij in lijn met de gedachte van de nog op te stellen opnametoets dienen te handelen. Wij veronderstellen dat u hiermee vooruitloopt op het nog nader uit te werken en vast te stellen afwegingskader. Welke vorm van controle voert het zorgkantoor uit op de naleving van deze verwachting?	3.1
In het inkoopbeleid verwijst u naar het toetsingskader voor het beleid rondom MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd. Wij nemen aan dat aanbieders dit toetsingskader alleen in hoeverre te zetten voor nieuwe cliënten, aansluitend bij de afspraken uit het HLO. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?	3.1
Mogen wij een cliënt weigeren een ongeclusterde VPT te bieden als deze niet aan het toetsingskader voldoet? Zo ja, waar baseert u dat op?	3.1
Met betrekking tot het beleid 'MPT in principe voorliggend op VPT ongeclusterd', veronderstellen wij dat een cliënt met een CIZ-indicatie het recht heeft om een leveringsvorm te kiezen. In hoeverre houdt u hiermee rekening met het recht dat de cliënt heeft uit hoofde van de WLZ? Kan het zorgkantoor aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met cliënten die hun recht op VPT ongeclusterd afdwingen?	3.1
De tarieven van MPT zijn voor onze organisatie niet kostendekkend. Bent u bereid - als gedeeltelijke compensatie daarvan - om voor de MPT-prestaties een tariefpercentage van 100% van het NZa-tarief overeen te komen? Zo, nee waarom niet?	3.1
Kunt u bevestigen of zorgaanbieders vanaf 2027 de principes mogen toepassen die Zorgkantoor DSW hanteert in de 'Pilot verminderd gebruik AAT en rekenmodule'?	3.1

Bent u het er mee eens als wij als zorgaanbieder vanaf 2027 de principes gaan toepassen zoals Zorgkantoor DSW deze hanteert in de "Pilot vermindering gebruik AAT en rekenmodule"? Dat betekent dat wij voor cliënten met MPT alleen een AAT in dienen als er een nieuwe aanbieder bij de zorg wordt betrokken, of als de leveringsvorm wijzigt, of als de zorg niet verantwoord geleverd kan worden. Zo nee, waarom niet?	
"De in het AZWA opgenomen afspraak over de nieuw te ontwikkelen prestatie én de opnametoets nemen wij hierin mee." Klopt de aanname dat hier het HLO vermeld dient te worden in plaats van het AZWA? Indien dit het geval is, kan het zorgkantoor dit aanpassen in het beleid?	3.4
Kan het zorgkantoor verduidelijken of de genoemde toepassingen bedoeld zijn als voorbeelden van kansrijke werkwijzen, of als concrete verwachting richting alle Wlz-aanbieders? En als het laatste het geval is: op basis van welke onderbouwing, voor welke doelgroepen en met welke randvoorwaarden en bekostiging?	3.5
Hoe beoordeelt het zorgkantoor of de innovatie bewezen effectief is? Wordt daarbij ook rekening gehouden met medewerkers- en clienttevredenheid, administratieve lastenverlichting, etc.?	3.5
Wij onderschrijven dat de genoemde innovaties veelbelovend kunnen zijn, mits zij zorgvuldig en contextafhankelijk worden geïmplementeerd. Wij zijn het echter niet eens met de stelling dat deze innovaties reeds bewezen effectief zijn binnen de intramurale setting. Voor sommige innovaties, waaronder beeldzorg, wordt bovendien nog gewerkt aan een gezamenlijk standpunt. Daarmee achten wij het te stellig om deze innovaties te presenteren als overal bewezen effectief, overal toepasbaar of zonder meer verplichtend. Wij verzoeken het zorgkantoor deze nuance expliciet in de passage te verwerken. Is het zorgkantoor bereid de passage op dit punt aan te passen? Zo nee, waarom niet?	3.5
In het inkoopbeleid wordt gesteld dat de zorgaanbieder ambassadeur is van het innovatietraject. Kunt u verduidelijken of Salland hierin wel cofinanciering beschikbaar stelt voor de innovatie? Indien dit niet het geval is, kunt u toelichten waarom ervoor gekozen is geen financiële bijdrage te leveren aan deze trajecten? Andere zorgkantoren hanteren voor innovatieprojecten immers wel vormen van cofinanciering.	3.5
U stelt: We overwegen daarbij geen 365 dagen volledig te vergoeden maar beschikbaarheid middels een opslag op gedeclareerde dagen te vergoeden. Kan het zorgkantoor toelichten hoe in de regio wordt geborgd dat er voldoende crisisbedden beschikbaar blijven?	3.9
U stelt: Ook verkennen we de mogelijkheden om doelmatigheidsafspraken uit te gaan breiden, bijvoorbeeld op het gebied van praktijkvariatie van MPT en VPT in de V&V-sector en de declaraties bij afwezigheid. Kan het zorgkantoor toelichten wat eventuele gevolgen zijn van deze 'verkenning'?	3.9

Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan de gehanteerde afslag van 2% voor nieuwe zorgaanbieders?	4.2
Kunt u toelichten of nieuwe zorgaanbieders in aanmerking komen voor op- en afslagen? Zo nee, kan het zorgkantoor juridisch onderbouwen waarom nieuwe zorgaanbieders hier geen aanspraak op kunnen maken?	4.2
In het inkoopbeleid koppelt u een afslag aan een zeer hoog rendement. Kunt u verduidelijken wat u onder 'een zeer hoog rendement' verstaat? En kunt u vervolgens toelichten op welke analyses de keuze voor deze grens is gebaseerd en welke betekenis aan deze grens wordt toegekend bij de beoordeling of een gesprek over het tarief plaatsvindt?	4.3
Kunt u toelichten hoe wordt omgegaan met zorgaanbieders waarvan het rendement zich rond de door het zorgkantoor gehanteerde grens bevindt en hoe een consistente toepassing wordt geborgd?	4.3
Kunt u toelichten welke mogelijke uitkomsten het genoemde gesprek bij 'een zeer hoog rendement' kan hebben en in hoeverre het zorgkantoor daarbij beleidsruimte heeft om het tarief aan te passen?	4.3
Kunt u toelichten welke afwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de keuze om bij 'een zeer hoog rendement' een gesprek over het tarief te voeren, mede in het licht van investeringen en continuïteit van zorg?	4.3
Hoe sluit u met deze passage aan bij de afspraken uit het HLO over behandeling? "De verhouding van zzp's mét en zonder behandeling blijft in principe ongewijzigd?"	4.5
Met ingang van 1 januari 2026 is de wet Domein overstijgende samenwerking (DOS) in werking getreden. Wanneer maakt het zorgkantoor het DOS-beleid bekend met de voorwaarden voor nieuwe projecten en de continuering van de bestaande projecten?	4.7
U geeft aan dat het inkoopbeleid DOS Preventieve Maatregelen naar verwachting medio juni 2026 wordt gepubliceerd. Eerder is gecommuniceerd dat dit beleid al in mei beschikbaar zou komen. Kunt u toelichten wat de oorzaak is van deze vertraging, mede gelet op het feit dat dit beleid ook nog betrekking heeft op 2026?	4.7
U geeft aan dat de doelstelling rondom een digitale infrastructuur voor u de hoogste prioriteit heeft en dat u hierover in gesprek wil met de regiotafel VV om tot afspraken te komen op dit thema. In het landelijke beleid is opgenomen dat zorgaanbieders voor alle vijf de thema's een aanvraag voor het Regiobudget HLO kunnen indienen. Kunt u bevestigen dat het voor zorgaanbieders mogelijk blijft om voor alle vijf de thema's een aanvraag voor het regiobudget in te dienen, conform het landelijke beleid? Zo nee, kunt u toelichten op welke gronden deze afwijking is gebaseerd?	5.1

Concept bezwaarbrief i.r.t. Zorginkoopbeleid

Deze e-mail is bedoeld om feitelijke informatie te delen naar aanleiding van vragen van leden van ActiZ. ActiZ geeft geen advies of aanbeveling over de wijze waarop u dient te contracteren en/of over het al dan niet inzetten van rechtsmiddelen. ActiZ treedt niet op namens individuele leden en verricht geen individuele beoordeling. Voor vragen over uw specifieke situatie dient u zelf juridisch advies in te winnen.

U kunt onderstaande bezwaarbrief aanpassen naar uw eigen situatie.

[naam en adres zorgkantoor]

t.a.v. Zorginkoop Langdurige Zorg

Betreft: Bezwaar tegen Zorginkoopbeleid Wlz 2027-2029

Geacht heer/mevrouw,

[zorgaanbieder] maakt bezwaar tegen het Zorginkoopbeleid Wlz 2027-2029 (hierna: "**Zorginkoopbeleid**") van uw zorgkantoor (hierna: "**het Zorgkantoor**"), in het bijzonder tegen de tariefsystematiek voortvloeiend uit het Zorginkoopbeleid alsmede uit Bijlage 7 (Onderbouwing vertrektarieven Wlz 2027) (hierna: "**Bijlage 7**").

De gekozen systematiek is naar haar inhoud en samenhang onvoldoende transparant en verbindt potentieel ingrijpende negatieve financiële gevolgen aan open en onvoorzienbare criteria. Daarmee is het Zorginkoopbeleid in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van transparantie, gelijke behandeling, zorgvuldigheid en evenredigheid, alsmede met het rechtszekerheidsbeginsel, welke beginselen het zorgkantoor zelf op deze inkoopprocedure van toepassing heeft verklaard.

Over de hiervoor genoemde pijnpunten zijn in het kader van de Nota van Inlichtingen vragen gesteld, omdat deze onderdelen van het Zorginkoopbeleid op dit moment onvoldoende duidelijk zijn. Dit bezwaar wordt tegelijkertijd ingediend, omdat de beantwoording van die vragen bepalend is voor de uitleg en toepassing van het beleid en wij willen voorkomen dat later wordt gesteld dat tegen deze onderdelen geen tijdig bezwaar is gemaakt.

De betreffende Nota van Inlichtingen (hierna: "**NvI**")-vragen zijn daarom integraal opgenomen als Bijlage 1 bij deze bezwaarbrief. Wij behouden ons het recht voor om, indien en voor zover de NvI leidt tot handhaving of wijziging van de bestreden onderdelen van voornoemde paragrafen en bijlagen, daartegen tijdig en zelfstandig rechtsmaatregelen aan te wenden. De bezwaren zijn hieronder opgenomen.

Bezwaren:

1. Het zorgkantoor beperkt de zorgaanbieders tot maximaal 400 tekens per vraag. Uitgaande van een gemiddelde van 6 letters per woord, is dit afgerond 67 woorden. In 67 woorden dient een zorgaanbieder volgens het Zorgkantoor een vraag te formuleren die (conform de vereisten van de Zorgkantoren) i) specifiek, ii) volledig, iii) duidelijk én iv) juist gesteld is, want alleen dan wordt de vraag in behandeling genomen.
 - a. Gelet op de omvang en complexiteit van het Zorginkoopbeleid en de tariefsystematiek vormt deze combinatie van vereisten aan de vraagstelling een voorzienbaar wezenlijke beperking van de mogelijkheid om bezwaren/vragen specifiek, duidelijk en volledig te formuleren.
 - b. het Zorgkantoor heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom deze beperking dringend noodzakelijk is, noch waarom minder ingrijpende alternatieven ontbreken. Er

worden kortom geen voorwaarden en criteria gesteld aan zorgaanbieders die in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht vermeld in het Zorginkoopbeleid. Daarmee is sprake van een disproportionele en onvoldoende zorgvuldig voorbereide beperking van het vragenrecht, die bovendien niet dragend is gemotiveerd.

2. Het voornemen van het Zorgkantoor om alle inhoudelijk verschillende vragen te bundelen onder één vraag leidt ertoe dat afzonderlijke bezwaren niet zelfstandig en volwaardig kunnen worden beoordeeld en getoetst.
 - a. Door het zelfstandig door het Zorgkantoor clusteren van vragen wordt:
 - i. de precisie van de vragen en antwoorden voorzienbaar verminderd;
 - ii. het risico vergroot dat vragen onvolledig of niet inhoudelijk worden beantwoord; en
 - iii. de mogelijkheid voor Zorgaanbieders beperkt om gericht en effectief op specifieke onderdelen van het Zorginkoopbeleid op te komen.
 - b. Hiermee wordt de kwaliteit en volledigheid van de beantwoording (structureel) onder druk gezet. Bovendien creëert de beoogde clustering van vragen het risico dat het Zorgkantoor vragen op meer algemene wijze beantwoordt, waarbij specifieke onderdelen niet afzonderlijk of volledig worden geadresseerd. Dit opent ruimte voor (onbedoelde) strategische beantwoording en beperkt de transparantie van de selectieprocedure.
 - c. Daarnaast brengt deze werkwijze het risico mee dat zorgaanbieders hun rechtsmiddelen niet of significant minder effectief kunnen benutten. Dat komt omdat hun vragen – door clustering waar zij geen stem in hebben – niet eenduidig herleidbaar of toetsbaar zijn. Hierdoor wordt de effectieve rechtsbescherming van zorgaanbieders aangetast. Dit geldt temeer nu het Zorgkantoor de zorgaanbieders verplicht om *al* hun bezwaren en vragen *voorafgaand* aan de NvI kenbaar te maken, op straffe van rechtsverwerking.
 - d. het Zorgkantoor heeft niet gemotiveerd hoe deze werkwijze zich verdraagt met een zorgvuldige en kenbare behandeling van vragen. Daarmee wordt de effectieve rechtsbescherming van zorgaanbieders beperkt en is sprake van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht.
3. In het Zorginkoopbeleid en Bijlage 7 is vastgelegd dat de tariefsystematiek wordt gebaseerd op gegevens uit jaar t-2. Deze gegevens zijn beslissend gemaakt voor zowel de clusterindeling als voor de tariefvorming binnen de clusters gedurende de gehele beleidsperiode. Het Zorginkoopbeleid maakt niet inzichtelijk waarom één historisch referentiejaar voor beide stappen bepalend wordt geacht, noch waarom deze keuze representatief is voor de kostenstructuur gedurende een meerjarige beleidsperiode. Door deze keuze zonder nadere motivering te maken, handelt het zorgkantoor in ieder geval in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.
 - a. Het zorgkantoor baseert de tariefsystematiek op gegevens uit jaar t-2. Deze gegevens zijn bepalend voor zowel de indeling van zorgaanbieders in clusters als voor de daarop gebaseerde tariefvorming. Het Zorginkoopbeleid ziet op de komende drie jaren 2027 t/m 2029.
 - b. Uit het Zorginkoopbeleid en Bijlage 7 blijkt niet waarom één historisch referentiejaar beslissend wordt geacht voor zowel de clusterindeling als de tariefvorming gedurende de gehele beleidsperiode 2027 t/m 2029, noch waarom deze keuze representatief is voor de kostenstructuur in de periode 2027 t/m 2029.
 - c. Nu een nadere motivering voor deze keuze ontbreekt, is onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom de tariefsystematiek, die in meerdere opzichten voortbouwt op t 2 gegevens, leidt tot tarieven die gedurende de gehele beleidsperiode 2027 t/m 2029

als reëel kunnen worden aangemerkt. Dit is in strijd met zowel het zorgvuldigheidsbeginsel als het transparantiebeginsel.

4. In Bijlage 7 worden zorgaanbieders geclusterd aan de hand van vaste grenswaarden. Het gaat dan o.a. om de indeling naar hoofdsector op basis van: (i) hoogste Wlz-omzet, (ii) een grens van 1% intramurale omzet en (iii) binnen de V&V-sector een grens van 85% VPT-omzet. Het Zorginkoopbeleid maakt niet inzichtelijk dat deze grenswaarden corresponderen met objectief vastgestelde en relevante verschillen in kostenstructuur of zorgverlening. Hierdoor bestaat het risico dat zorgaanbieders die in materieel opzicht vergelijkbaar zijn, verschillend worden behandeld zonder objectieve rechtvaardiging. Dit is onverenigbaar met het gelijkheidsbeginsel. Dit bezwaar richt zich mede tegen de cumulatieve werking van deze grenswaarden in onderlinge samenhang.
 - a. Uit bijlage 7 bij het Zorginkoopbeleid volgt dat de clusterindeling van zorgaanbieders in drie stappen plaatsvindt: (i) indeling naar hoofdsector op basis van hoogste Wlz omzet, (ii) onderscheid tussen extramuraal en (gedeeltelijk) intramuraal op basis van een vaste grens van 1% intramurale omzet, en (iii) binnen de V&V sector een onderscheid tussen hoofdzakelijk VPT en divers extramuraal op basis van een vaste grens van 85% VPT omzet. Deze indeling is bepalend voor het toepasselijke vertrektarief.
 - b. Uit het Zorginkoopbeleid en Bijlage 7 blijkt niet waarom juist deze vaste grenswaarden zijn gekozen, noch dat zij corresponderen met objectief vastgestelde verschillen in de kostenstructuur. In het bijzonder is niet inzichtelijk gemaakt welk deel van de kostenverschillen tussen VPT-aanbieders en andere extramurale aanbieders samenhangt met zorgverlening en welk deel met wonen en aanverwante componenten, en waarom juist bij een aandeel van 85% een relevant kantelpunt ontstaat dat bepalend is voor het vertrektarief.
 - c. Nu deze onderbouwing ontbreekt, is onvoldoende gemotiveerd dat de gekozen clusteringssystematiek leidt tot reële tarieven voor zorgaanbieders met vergelijkbare zorgkosten. Daarmee bestaat het risico van ongerechtvaardigd onderscheid, hetgeen spanning oproept met het gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel bij de inrichting en toepassing van het tariefmodel.
5. Hoewel het Zorginkoopbeleid formeel uitgaat van één landelijk tariefmodel, leidt de manier waarop clustering, sturing op leveringsvormen en capaciteits- en volumebeperkingen samen worden toegepast tot een feitelijke afwaardering van bepaalde leveringsvormen, met name ongeclusterd VPT. Deze afwaardering wordt niet gepresenteerd als een expliciete tariefkorting, maar werkt in de praktijk wel zo uit. De vergoeding komt lager uit en uitbreiding of voortzetting van deze leveringsvorm wordt beperkt. Daarmee worden financiële gevolgen veroorzaakt die in het beleid niet als zodanig zijn benoemd of afzonderlijk zijn gemotiveerd. Dit is problematisch in het licht van het transparantie- en evenredigheidsbeginsel.
6. Het Zorginkoopbeleid beschrijft verschillende beleidsinstrumenten afzonderlijk (zoals clustering, sturing op MPT/VPT en capaciteits- en volumesturing), maar laat na inzichtelijk te maken wat deze maatregelen gezamenlijk betekenen voor de financiële positie en kostendekkendheid van het tarief. In de praktijk grijpen deze instrumenten op elkaar in en versterken zij elkaar, terwijl het beleid geen totaalbeeld geeft van dat effect. Daardoor kunnen zorgaanbieders niet goed beoordelen wat het beleid in samenhang voor hen betekent. Dit is in strijd met het zorgvuldigheids- en transparantiebeginsel.
7. Door tegelijkertijd te sturen op afbouw van intramurale capaciteit, omzetting van capaciteit naar andere sectoren en het beperken van uitbreidingsmogelijkheden voor bepaalde leveringsvormen, ontstaat een financieel effect dat feitelijk neerkomt op een tariefverlaging, zonder dat daar een expliciete tariefbeslissing of tariefgrondslag tegenover staat.

Zorgaanbieders krijgen te maken met lagere opbrengsten en hogere druk ten aanzien van vaste lasten, terwijl deze gevolgen niet afzonderlijk zijn afgewogen of gemotiveerd. Deze indirecte tariefwerking is moeilijk verenigbaar met het evenredigheids- en rechtszekerheidsbeginsel.

8. Hoewel het tariefmodel landelijk uniform is, verschilt de mate waarin zorgkantoren sturen op leveringsvormen, capaciteit en volume in de praktijk aanzienlijk. Hierdoor hangt de feitelijke vergoeding en de ruimte om zorg te leveren of uit te breiden in sterke mate af van het zorgkantoor waaronder een aanbieder valt. Zorgaanbieders met een vergelijkbare kostenstructuur en vergelijkbare prestaties worden daardoor geconfronteerd met wezenlijk verschillende uitkomsten. Dat leidt tot een ongelijk speelveld en raakt aan het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel.
9. In het Zorginkoopbeleid en Bijlage 7 wordt het 75e percentiel gehanteerd als basis voor het vertrektarief per cluster, onder verwijzing naar eerdere rechtspraak. Uit die rechtspraak volgt echter niet dat toepassing van dit percentiel zonder meer leidt tot reële tarieven. In het huidige model vormt het 75e percentiel het eindpunt van een reeks voorafgaande selecties en correctiemechanismen. Het Zorginkoopbeleid maakt niet inzichtelijk welk cumulatief effect deze keuzes hebben op de tariefuitkomst en of het percentiel in deze concrete context nog leidt tot tarieven die voor een representatief deel van de zorgaanbieders reëel zijn. Het ontbreken van een samenhang- en effecttoets is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.
 - a. In Bijlage 7 bij het Zorginkoopbeleid wordt bij de vaststelling van het vertrektarief verwezen naar eerdere rechtspraak waarin het hanteren van het 75e percentiel als methode is aanvaard. Uit het [arrest](#) van het Hof Den Haag volgt echter niet dat het toepassen van dit percentiel zonder meer leidt tot reële tarieven.
 - b. Het Hof verlangt dat wordt beoordeeld of de concrete uitwerking van de tariefsystematiek, in onderlinge samenhang bezien, leidt tot tarieven die voor een representatief deel van de zorgaanbieders reëel zijn. De enkele aanvaarding van het 75e percentiel zegt daarom niets over de rechtmatigheid van de uitkomst wanneer dit percentiel pas wordt toegepast na voorafgaande clustering, vaste grenswaarden en correcties.
 - c. Juist omdat het 75e percentiel in dit model het eindpunt vormt van een reeks selecties en correcties, had het zorgkantoor inzichtelijk moeten maken welk effect deze voorafgaande keuzes hebben op de tariefuitkomst en of het percentiel in deze concrete context nog leidt tot reële tarieven. Een dergelijke samenhang en effecttoets blijkt uit het Zorginkoopbeleid en de bijlagen niet.
10. In het Zorginkoopbeleid en Bijlage 7 is opgenomen dat financieringslasten worden gecorrigeerd vanwege een veronderstelde overlap met de NHC/NIC, terwijl het kostenpercentage wordt bepaald ten opzichte van een NZa-maximumtarief exclusief NHC/NIC. De NHC/NIC vormt echter een normatieve vergoeding voor kapitaallasten en is niet noodzakelijk gelijk aan de feitelijke financieringslasten van individuele zorgaanbieders. Door deze systematiek functioneert het model alsof de normatieve vergoeding de feitelijke vastgoedkosten dekt, zonder dat is vastgesteld in hoeverre dit per zorgaanbieder daadwerkelijk het geval is. Dit bezwaar ziet expliciet op zowel de kostenkantcorrectie als de NZa-referentiekant. Het buiten beschouwing laten van feitelijke financieringslasten zonder nadere verifieerbare analyse is onverenigbaar met het zorgvuldigheidsbeginsel.
 - a. De NHC/NIC vormt een normatieve vergoeding voor kapitaallasten en is niet noodzakelijk gelijk aan de feitelijke financieringslasten en -baten van individuele zorgaanbieders. Dat betekent dat niet zonder nadere verifieerbare analyse kan worden aangenomen dat sprake is van een volledige overlap tussen de NHC/NIC-vergoeding en de in de jaarrekening opgenomen financieringslasten.

- b. Door financieringslasten aan de kostenkant te corrigeren en het kostenpercentage te bepalen ten opzichte van een NZa-maximumtarief exclusief NHC/NIC, functioneert de tariefsystematiek alsof de normatieve NHC/NIC-vergoeding de feitelijke vastgoedkosten dekt, zonder dat is vastgesteld in hoeverre dit per aanbieder daadwerkelijk het geval is. Zonder inzicht in de omvang van deze veronderstelde overlap worden feitelijke kosten buiten beschouwing gelaten op basis van een normatieve aanname.
- c. Daarmee is niet inzichtelijk gemaakt dat financieringslasten hun betekenis voor de tariefvorming behouden, zoals het Hof Den Haag haar [arrest](#) (r.o. 6.26) heeft benadrukt.

[INDIEN BEZWAAR BIJ ZORGKANTOOR VGZ]

- 11. In paragraaf 3.1 (Tariefsystematiek) is bepaald dat bij een rendement van meer dan 5% het gesprek kan worden aangegaan over een mogelijk lager tarief. Hoewel rendement wordt gedefinieerd als nettoresultaat gedeeld door de som der bedrijfsopbrengsten, blijft onduidelijk over welke periode dit rendement wordt vastgesteld en op basis van welke financiële gegevens. De keuze voor een vaste grens van 5% is niet objectief onderbouwd en leidt tot het risico van ongelijke behandeling bij marginale verschillen. De hantering van deze harde rendementsgrens zonder nadere onderbouwing verdraagt zich niet met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Dit bezwaar richt zich tevens op het ontbreken van een onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten. Voorts is niet gemotiveerd waarom een verhoogd totaalondernemingsrendement aanleiding zou moeten zijn voor een lager zorgtarief, hetgeen strijdig is met het evenredigheidsbeginsel.
- 12. Eveneens in paragraaf 3.1 (Tariefsystematiek) wordt bepaald dat het tarief mede afhankelijk kan zijn van de "bijdrage in de regio". Het zorginkoopbeleid maakt niet inzichtelijk wat onder deze bijdrage wordt verstaan, welke bijdragen relevant zijn en hoe deze worden beoordeeld en gewogen. Evenmin is duidelijk hoe deze beoordeling doorwerkt in de tariefvaststelling. Het hanteren van een open norm zonder toetsbare criteria is onverenigbaar met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel.

[INDIEN BEZWAAR BIJ ZORGKANTOOR CZ]

- 13. Hoewel CZ in het Zorginkoopbeleid verwijst naar het landelijke tariefmodel en de uniforme clustering, bevat het beleid formuleringen waarin tarief- en doelmatigheidsaspecten expliciet worden verbonden aan regionale beleidsdoelstellingen, zoals kostensturing, transformatie en het uitgangspunt "thuis, tenzij". Dit roept de vraag op of en in hoeverre de landelijke, uniforme tariefsystematiek (t-2-gegevens, clustering en het 75e percentiel) strikt gescheiden blijft van regionale beleidsmatige afwegingen. Dit raakt aan het gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel, alsmede het daarmee samenhangende rechtszekerheidsbeginsel, nu deze systematiek landelijk uniform en niet beleidsmatig beïnvloedbaar is. Ter voorkoming van onduidelijkheid wordt verzocht expliciet te bevestigen dat CZ de landelijke tariefsystematiek onverkort, objectief en zonder beleidsmatige inkleuring toepast.
- 14. Paragraaf 4.3.2 van het Zorginkoopbeleid van CZ bepaalt dat hoog positieve financiële resultaten aanleiding kunnen zijn voor een heroverweging van tarief- of contractafspraken. Het Zorginkoopbeleid bevat echter geen objectieve rendementsnorm, noch een bandbreedte of andere toetsbare maatstaf. Evenmin is verduidelijkt over welke periode en op basis van welke financiële gegevens deze beoordeling plaatsvindt, en ontbreekt een onderscheid tussen incidentele en structurele resultaten. Hierdoor ontbreekt een vooraf kenbare en toetsbare norm, terwijl de mogelijke gevolgen ten aanzien van de aanpassing van het tarief aanzienlijk kunnen zijn. Deze vorm van rendementssturing zonder nadere onderbouwing verdraagt zich niet met het transparantie- en rechtszekerheidsbeginsel en kan leiden tot

willekeurige toepassing, hetgeen strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast is niet gemotiveerd waarom een hoog ondernemingsresultaat aanleiding zou moeten zijn voor een lager zorgtarief, hetgeen strijdig is met het evenredigheidsbeginsel.

[INDIEN BEZWAAR BIJ ZORGKANTOOR Zilveren Kruis]

15. Het Zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis bevat een vergaande en expliciete sturing op de gewenste leveringsmix, waaronder op MPT, VPT, intramuraal en regionale monitoring en bijsturing daarop. Voor zover uit het beleid of de toepassing daarvan de indruk kan ontstaan dat aanbieders met een bepaalde leveringsmix (bijvoorbeeld een relatief hoog aandeel VPT) binnen of door de toepassing van de landelijke tariefsystematiek ongunstiger worden gepositioneerd, wordt daartegen bezwaar gemaakt. Dit raakt aan het gelijkheids- en transparantiebeginsel, nu de landelijke clustering en het 75e percentiel uitsluitend mogen zijn gebaseerd op objectieve, historische t-2-gegevens en los dienen te staan van regionale leveringsmix-doelstellingen. Verzocht wordt dit expliciet te bevestigen.
16. In het Zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis wordt de toegang tot en inzet van meerzorg beleidsmatig begrensd of ontmoedigd. Meerzorg is echter bedoeld als cliëntvolgend instrument voor uitzonderlijke en zwaar complexe zorgsituaties en kan niet worden behandeld als regulier beleidsmatig sturingsmiddel. Door aanvullende drempels, plafonds of terughoudendheid in de inzet van meerzorg ontstaat het risico dat noodzakelijke zorg niet of onvoldoende wordt gefinancierd, terwijl de zorgvraag objectief vaststaat. Dit raakt aan het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel, en kan bovendien spanning opleveren met de zorgplicht, doordat de financiële verantwoordelijkheid feitelijk bij de zorgaanbieder wordt neergelegd.
17. In paragraaf 3.2 van het Zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis is bepaald dat bij een hoog positief financieel resultaat het gesprek kan worden aangegaan over herijking van tarief- en/of contractafspraken. Daarbij ontbreekt een objectieve rendementsdrempel of bandbreedte. Evenmin is duidelijk over welke periode het resultaat wordt beoordeeld en op basis van welke financiële gegevens. Ook maakt het beleid geen onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten. Door deze open rendementssturing is voor zorgaanbieders niet voorzienbaar wanneer ingrijpen volgt en welke gevolgen daaraan worden verbonden. Dit verdraagt zich niet met het transparantie- en rechtszekerheidsbeginsel en leidt tot het risico van ongelijke behandeling, hetgeen strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Voorts is niet gemotiveerd waarom een verhoogd totaalondernemingsresultaat aanleiding zou moeten zijn voor een lager zorgtarief, hetgeen strijdig is met het evenredigheidsbeginsel.

[INDIEN BEZWAAR BIJ ZORGKANTOOR Menzis]

18. Het Zorginkoopbeleid van Menzis verwijst naar het landelijke tariefmodel en de aanpassing die is doorgevoerd naar aanleiding van de dubbele verwerking van financiële baten en lasten. Deze aanpassing bestaat eruit dat financiële baten en lasten uit het kostenniveau van het tariefmodel zijn geëlimineerd, terwijl de NHC/NIC-component onverkort op 100% wordt vergoed, teneinde dubbele verwerking te voorkomen. Het beleid maakt echter niet expliciet inzichtelijk hoe deze meervoudige aanpassing concreet is doorgevoerd in de vaststelling van het vertrektariefpercentage. Dit raakt aan het transparantie- en zorgvuldigheidsbeginsel. Ter voorkoming van rechtsverwerking wordt verzocht te bevestigen dat deze aanpassing volledig, consistent en identiek aan de landelijke methodiek is toegepast, zonder resterende overlap tussen tariefmodel en NHC/NIC-vergoeding.
19. Het Zorginkoopbeleid van Menzis verbindt het gebruik of de implementatie van KIK-V aan contractuele verwachtingen. KIK-V is primair een kwaliteits- en verantwoordingsinstrument en geen inkoop- of tariefvoorwaarde. Voor zover naleving van KIK-V gevolgen heeft voor contractering, volume, tarief of beoordeling van doelmatigheid, wordt een

kwaliteitsinstrument ingezet als financieel sturingsmiddel. Dit is onvoldoende gemotiveerd en raakt aan het transparantie- en zorgvuldigheidsbeginsel, nu niet duidelijk is welke concrete gevolgen aan niet-naleving worden verbonden en op welke grondslag.

[INDIEN BEZWAAR BIJ ZORGKANTOOR Salland]

20. Hoewel Salland in het Zorginkoopbeleid verwijst naar het landelijke tariefmodel en de uniforme clustering, worden tarief- en volumeafspraken in het beleid sterk verbonden aan regionale beleidsaccenten en agenda's. Voor zover dit de indruk kan wekken dat de landelijke clustering en het 75e percentiel worden gebruikt als regionaal sturingsinstrument, wordt daartegen bezwaar gemaakt. Dit raakt aan het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel, nu de landelijke tariefsystematiek ertoe strekt zorgkantoor-specifieke interpretatie of beleidsmatige inkleuring te voorkomen. Ter voorkoming van onduidelijkheid wordt verzocht expliciet te bevestigen dat clustering, percentiel en t-2-systematiek zuiver landelijk, uniform en beleidsneutraal zijn toegepast.
21. In het Zorginkoopbeleid van Salland wordt tevens de toegang tot en inzet van meerzorg beleidsmatig begrensd of ontmoedigd. Meerzorg is echter bedoeld als cliëntvolgend instrument voor uitzonderlijke en zwaar complexe zorgsituaties en kan niet worden behandeld als regulier beleidsmatig sturingsmiddel. Door aanvullende drempels, plafonds of terughoudendheid in de inzet van meerzorg ontstaat het risico dat noodzakelijke zorg niet of onvoldoende wordt gefinancierd, terwijl de zorgvraag objectief vaststaat. Dit raakt aan het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel, en kan bovendien spanning opleveren met de zorgplicht, doordat de financiële verantwoordelijkheid feitelijk bij de zorgaanbieder wordt neergelegd.
22. Het Zorginkoopbeleid van Salland verbindt het gebruik of de implementatie van KIK-V aan contractuele verwachtingen. KIK-V is primair een kwaliteits- en verantwoordingsinstrument en geen inkoop- of tariefvoorwaarde. Voor zover naleving van KIK-V gevolgen heeft voor contractering, volume, tarief of beoordeling van doelmatigheid, wordt een kwaliteitsinstrument ingezet als financieel sturingsmiddel. Dit is onvoldoende gemotiveerd en raakt aan het transparantie- en zorgvuldigheidsbeginsel, nu niet duidelijk is welke concrete gevolgen aan niet-naleving worden verbonden en op welke grondslag.
23. In paragraaf 4.3 van het Zorginkoopbeleid van Salland wordt verwezen naar bovenmatige of niet-passende financiële resultaten als aanleiding voor heroverweging van tarief- of contractafspraken. Het beleid laat echter volledig in het midden wanneer sprake is van een bovenmatig resultaat en bevat geen objectieve norm, percentage of bandbreedte. Ook is niet verduidelijkt over welke periode en op basis van welke financiële gegevens het resultaat wordt vastgesteld, noch wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele resultaten. Door deze open rendementssturing zonder nadere normering ontstaat rechtsonzekerheid en het risico van ongelijke behandeling. Dit verdraagt zich niet met het transparantie- en rechtszekerheidsbeginsel en raakt tevens het gelijkheidsbeginsel. Evenmin is gemotiveerd waarom een verhoogd totaalondernemingsresultaat aanleiding zou moeten zijn voor een lager zorgtarief, hetgeen strijdig is met het evenredigheidsbeginsel.

[INDIEN BEZWAAR BIJ ZORGKANTOOR DSW]

24. Dit bezwaar richt zich zowel tegen (i) de toepassing van de in paragraaf 3.5 en Bijlage 2 van het Zorginkoopbeleid van DSW opgenomen correctiemaatregelen, als tegen (ii) de beleidsmatige bevoegdheid van DSW om bij krapte in het regiobudget de vergoeding voor geleverde zorg eenzijdig neerwaarts aan te passen.
25. In paragraaf 3.5 is bepaald dat bij krapte in het regionale budget correctiemaatregelen worden toegepast op de financiële afspraken met zorgaanbieders. Uit de uitwerking in Bijlage 2 volgt dat deze maatregelen niet beperkt blijven tot volumesturing, maar materieel leiden tot een achteraf en eenzijdig toegepaste neerwaartse bijstelling van de vergoeding voor

reeds geleverde, rechtmatig gedeclareerde zorg. Het terugvallen op eerdere ZZP/VPT-mixen, het maximaliseren van intramurale capaciteit en correcties bij MPT-zorg op basis van regionale gemiddelden hebben tot gevolg dat zorg die binnen de Wlz-kaders is geleverd niet (volledig) wordt vergoed.

26. Dat het formele tariefpercentage ongewijzigd blijft, is daarbij niet doorslaggevend. Beslissend is de feitelijke vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt, en die wordt door deze correcties verlaagd. Daarmee functioneert de regeling bij budgetkrapte materieel als een eenzijdige aanpassing van de vergoeding, hetgeen onvoldoende transparant en voorzienbaar is en spanning oplevert met het rechtszekerheids-, zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel.

Verzoek tot onmiddellijke aanpassing

Gelet op het voorgaande verzoeken wij het zorgkantoor het Zorginkoopbeleid per ommegaande aan te passen. De aanpassingen behelzen dat de tariefsystematiek en de daarin opgenomen correcties en discretionaire aanpassingsmechanismen worden voorzien van duidelijke, objectieve en toetsbare criteria die vooraf kenbaar worden gemaakt en tevens kenbaar wordt welke rechtsgevolgen aan toepassing zijn verbonden en dat tariefaanpassingen uitsluitend plaatsvinden op basis van een zorgvuldig voorbereide en evenredige belangenafweging. Zolang deze verduidelijking en normering ontbreken, kunnen de betreffende bepalingen niet rechtmatig worden toegepast binnen de lopende inkoopprocedure.

[zorgaanbieder] behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en weren voor.

Hoogachtend,

[naam]

[functie / kantoor]